Buku Panduan DeciBridge

Kasus latihan ARNI vs Ramipril pada HFrEF

Langkah demi langkah dari menu Ringkasan sampai Versi, dengan tangkapan layar

Kasus: `DB_DEMO_HF_001`
Sumber data: DeciBridge_Demo_Training_Package.xlsx
Build aplikasi: v1.0.0 - 4e42330
Disusun: 27 Oktober 2026

Data latihan sintetis

Seluruh angka dalam panduan ini berasal dari paket latihan dan dibuat khusus untuk pembelajaran. Angka-angka itu bukan data pasien, bukan data rumah sakit, dan tidak boleh dipakai untuk keputusan klinis atau formularium yang sebenarnya.

Tentang panduan ini

Panduan ini menunjukkan cara mengerjakan satu kasus lengkap di DeciBridge, mengikuti Paket Data Demo (DeciBridge_Demo_Training_Package.xlsx) dari menu Ringkasan sampai Versi. Setiap bab menyebut nomor langkah pada sheet 01_STEP_BY_STEP paket, nilai yang diketik, peran yang mengerjakan, dan hasil yang seharusnya muncul di layar.

Semua tangkapan layar diambil dari satu kali pengerjaan kasus `DB_DEMO_HF_001` pada database kosong, dengan build 4e42330. Angka pada tabel hasil dikutip langsung dari pengerjaan itu dan dicocokkan dengan 11_INSTRUCTOR_KEY pada Lampiran A.

Cara membaca panduan

- Teks **tebal** adalah nama tombol, tab, atau isian persis seperti di layar.
- Teks `seperti ini` adalah nilai yang diketik persis seperti tertulis. Desimal memakai titik, bukan koma: `0.30`.
- Kotak biru berisi catatan, kotak kuning berisi hal yang sering keliru, dan kotak hijau berisi angka untuk mencocokkan hasil.
- Tempat dashboard berbeda dari paket latihan dirangkum pada Lampiran B.

Bila berlatih di situs bersama

Kasus `DB_DEMO_HF_001` sudah tersedia di sana sebagai rujukan, dan satu ID kasus hanya dapat dipakai sekali. Buat kasus dengan ID sendiri, misalnya `INISIAL_DEMO_HF_001`, lalu ikuti langkah yang sama. Jangan mengubah kasus milik orang lain.

Isi panduan

Bab	Menu	Langkah paket	Peran yang mengerjakan
1	Persiapan: akun, peran, dan cara masuk	-	Semua
2	Ringkasan	1-10	Analis HTA
3	Analisis Ekonomi	11-24	Analis HTA
4	BIA	25-34	Analis HTA
5	PSA	35-40	Analis HTA
6	EtD	41-49	Analis HTA, lalu Anggota KFT
7	Rekomendasi	50-53	Sekretaris KFT, Analis HTA, lalu Anggota KFT
8	Sign-Off	54-55	Analis HTA, lalu Ketua KFT
9	Brief	56	Analis HTA
10	Versi	55, 57-59	Ketua KFT, Analis HTA dan Anggota KFT
A	Lampiran: kunci hasil		
B	Lampiran: perbedaan paket latihan dan dashboard		
C	Lampiran: masalah yang sering terjadi		

1. Persiapan

1.1 Peran dan akun

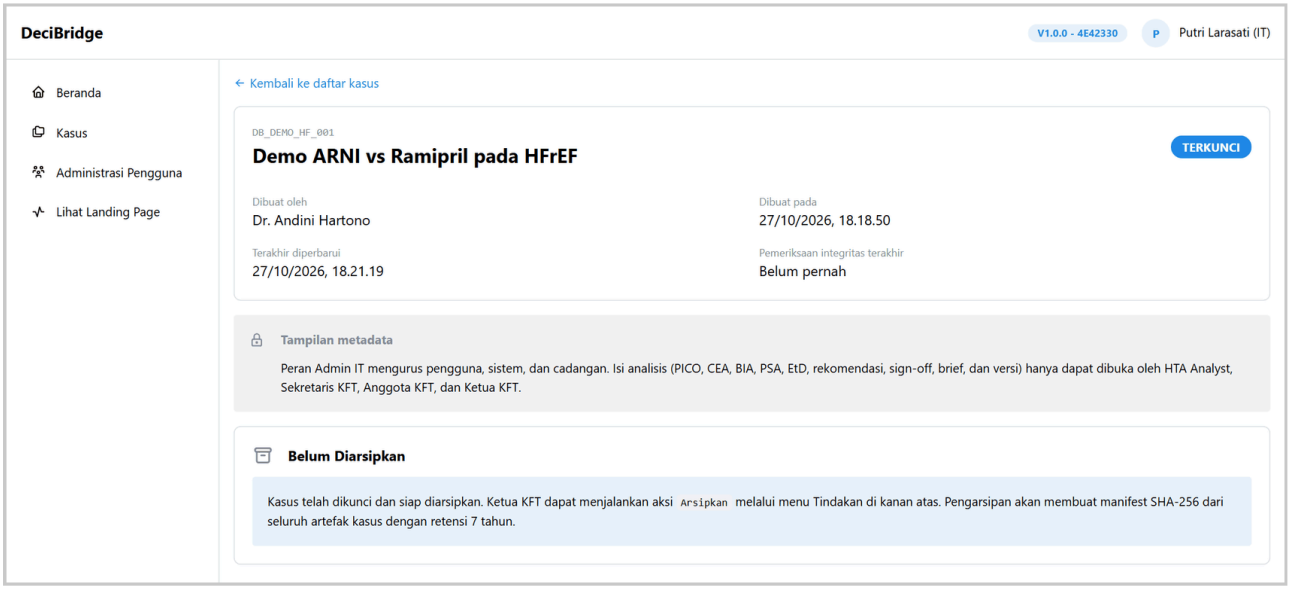
DeciBridge membagi pekerjaan menurut peran. Satu kasus baru selesai setelah keempat peran di bawah ini mengerjakan bagiannya. Orang yang berlatih sendiri perlu berganti akun pada setiap pergantian peran: klik nama di kanan atas, pilih **Keluar**, lalu masuk dengan akun berikutnya.

Tabel 1. Peran, akun demo, dan pekerjaannya

Peran	Akun demo	Yang dikerjakan dalam panduan ini
Analis HTA / Farmakoekonomi	`hta@test.local`	Membuat kasus; mengisi Analisis Ekonomi, BIA, PSA dan referensi; menghitung rekomendasi; mengajukan kasus; menerbitkan brief
Sekretaris KFT / Farmasi RS	`sekre@test.local`	Mengisi kriteria akses (CBA)
Anggota KFT	`kft1@test.local`	Menilai sembilan domain EtD; mencatat Keputusan Final KFT beserta alasannya
Ketua KFT	`ketua@test.local`	Menandatangani sign-off, mengunci keputusan, membuat revisi sebagai versi baru
Admin IT	`adminit@test.local`	Tidak membuka isi kasus; mengelola pengguna, memantau status dan integritas kasus, dan memeriksa segel arsip

Kata sandi akun demo tertulis di halaman masuk, pada bagian **Akun demo**.

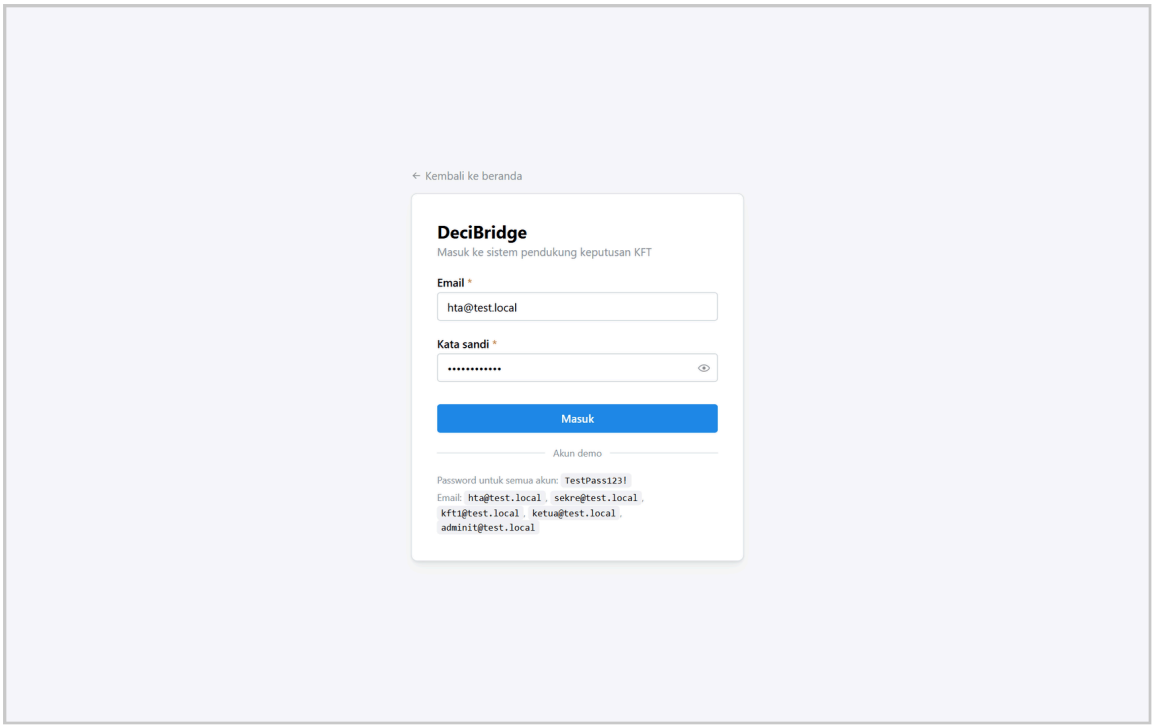
Admin IT mengurus pengguna, sistem dan cadangan. Pada daftar kasus dan halaman kasus, Admin IT hanya melihat metadata: ID, judul, status, tanggal, integritas, dan segel arsip. Isi analisis tidak dapat dibuka, dan Admin IT tidak dapat mengubah analisis maupun menerbitkan keputusan.



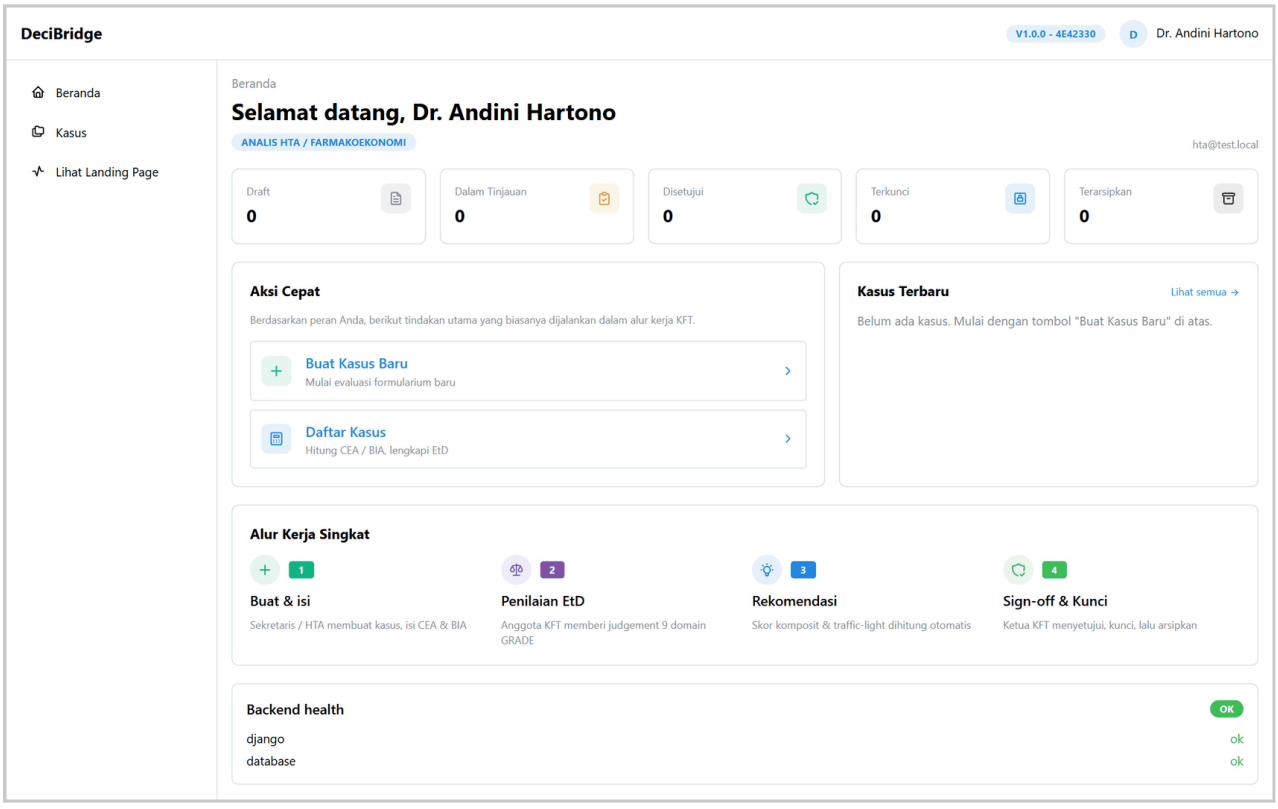
Gambar 1. Kasus latihan dilihat Admin IT: metadata saja.

1.2 Masuk

1. Buka alamat aplikasi, lalu buka halaman masuk.
2. Isi **Email** dan **Kata sandi**, lalu klik **Masuk**.
3. Halaman **Beranda** terbuka. Nama dan peran akun tampil di bagian atas.



Gambar 2. Halaman masuk. Daftar akun demo ada di bagian bawah kartu.



Gambar 3. Beranda Analis HTA sebelum ada kasus.

1.3 Urutan kerja

Sembilan menu kasus dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Tiga menu pertama setelah Ringkasan menghitung bukti ekonomi, EtD dan Rekomendasi menimbangnya, lalu Sign-Off, Brief dan Versi mencatat keputusannya.

Tabel 2. Status kasus sepanjang alur

Status kasus	Terjadi ketika	Yang masih dapat diubah
Draft	Kasus baru dibuat	Semua isian
Dalam Tinjauan	Analis HTA memilih **Ajukan untuk Tinjauan**	Semua isian; Ketua KFT dapat menandatangani
Disetujui	Ketua KFT menandatangani sign-off	Brief dapat diterbitkan; Ketua KFT dapat meminta revisi
Terkunci	Ketua KFT memilih **Kunci Keputusan**	Tidak ada. Untuk mengubah, Analis HTA atau Ketua KFT memilih **Buat Revisi (Versi Baru)**; kasus kembali ke Draft sebagai versi berikutnya dan versi terkunci tetap utuh

2. Menu 1 - Ringkasan

Peran: Analis HTA **Langkah paket:** 1-10

Menu Ringkasan memuat identitas kasus dan pertanyaan keputusannya (PICO). Isinya diketik satu kali ketika kasus dibuat, melalui tiga langkah.

1. Di **Beranda**, klik **Buat Kasus Baru**.
2. Langkah **Identitas**: isi **ID Kasus** dan **Judul Kasus**, lalu klik **Lanjut**.
3. Langkah **Klinis**: isi **Intervensi (Teknologi)**, **Komparator**, **Indikasi**, **Populasi** dan **Setting**. Biarkan **Perspektif** pada **Rumah Sakit**. Klik **Lanjut**.
4. Langkah **PICO**: isi **Pertanyaan klinis** dan keempat unsur PICO, lalu klik **Lanjut**.
5. Periksa ringkasan, lalu klik **Simpan Kasus**. Kasus terbuka pada tab **Ringkasan** dengan status **DRAFT**.

Tabel 3. Isian Ringkasan

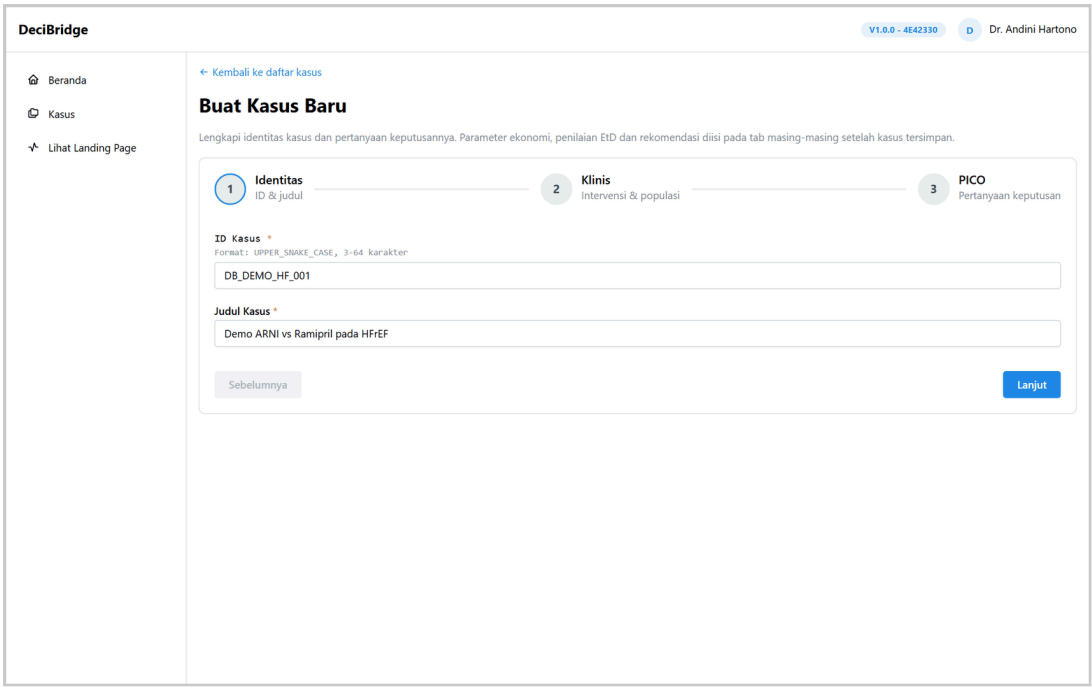
Isian	Nilai yang diketik	Langkah
ID Kasus	`DB_DEMO_HF_001`	1
Judul Kasus	Demo ARNI vs Ramipril pada HFrEF	2
Indikasi	Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF)	3
Populasi	Dewasa >=18 tahun, HFrEF LVEF <=40%, NYHA II-IV, stabil	4
Intervensi (Teknologi)	Sacubitril/valsartan (ARNI)	5
Komparator	Ramipril (ACEI)	6
Setting	Formularium rumah sakit; rawat jalan HFrEF	7
Perspektif	Rumah Sakit	8
Pertanyaan klinis	Apakah ARNI diadopsi dibanding ramipril untuk pasien HFrEF eligible?	-
Populasi (P), Intervensi (I), Komparator (C)	Sama dengan isian di atas	4-6
Outcome (O)	QALY; rehospitalisasi HF	10

Dua isian paket yang letaknya berbeda

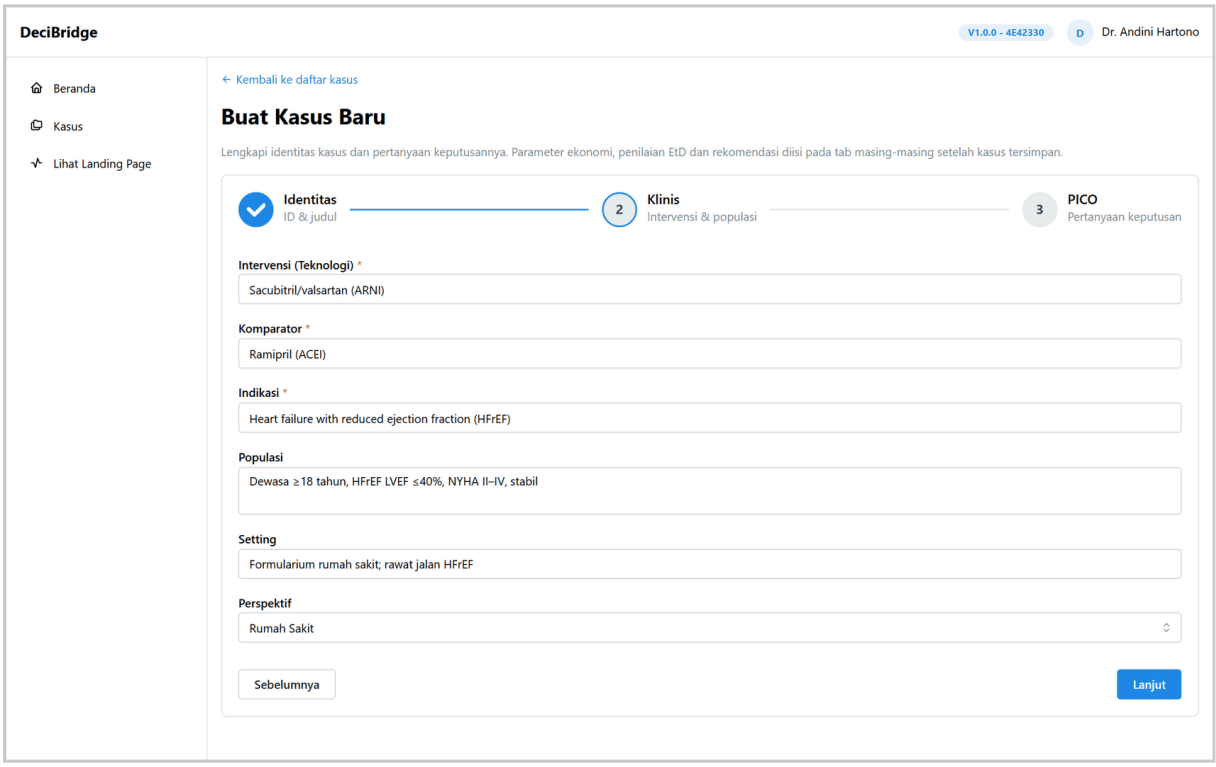
Time horizon (langkah 9) tidak diisi di sini. Isian itu ada di menu Analisis Ekonomi sebagai **Horizon CEA (tahun)**.

Outcome (langkah 10) diisi pada **Outcome (O)** di langkah PICO.

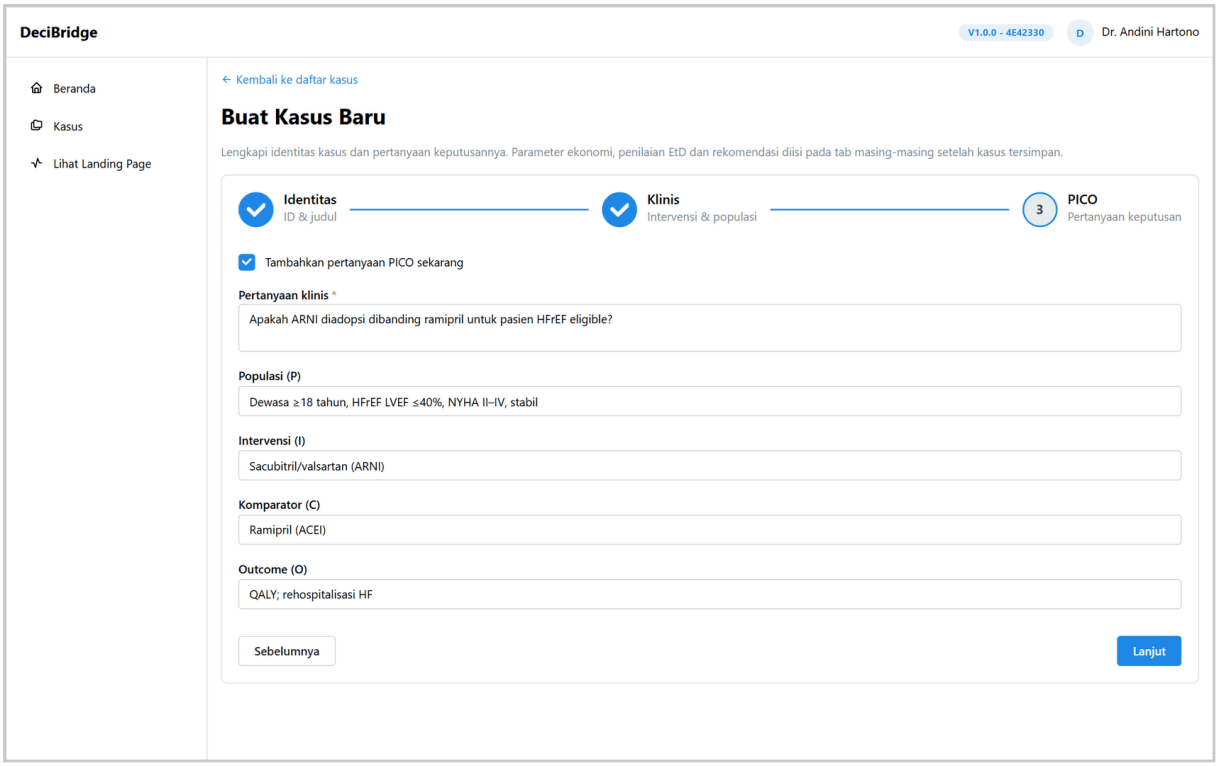
ID kasus hanya menerima huruf besar, angka dan garis bawah, dan tidak dapat diubah setelah kasus disimpan.



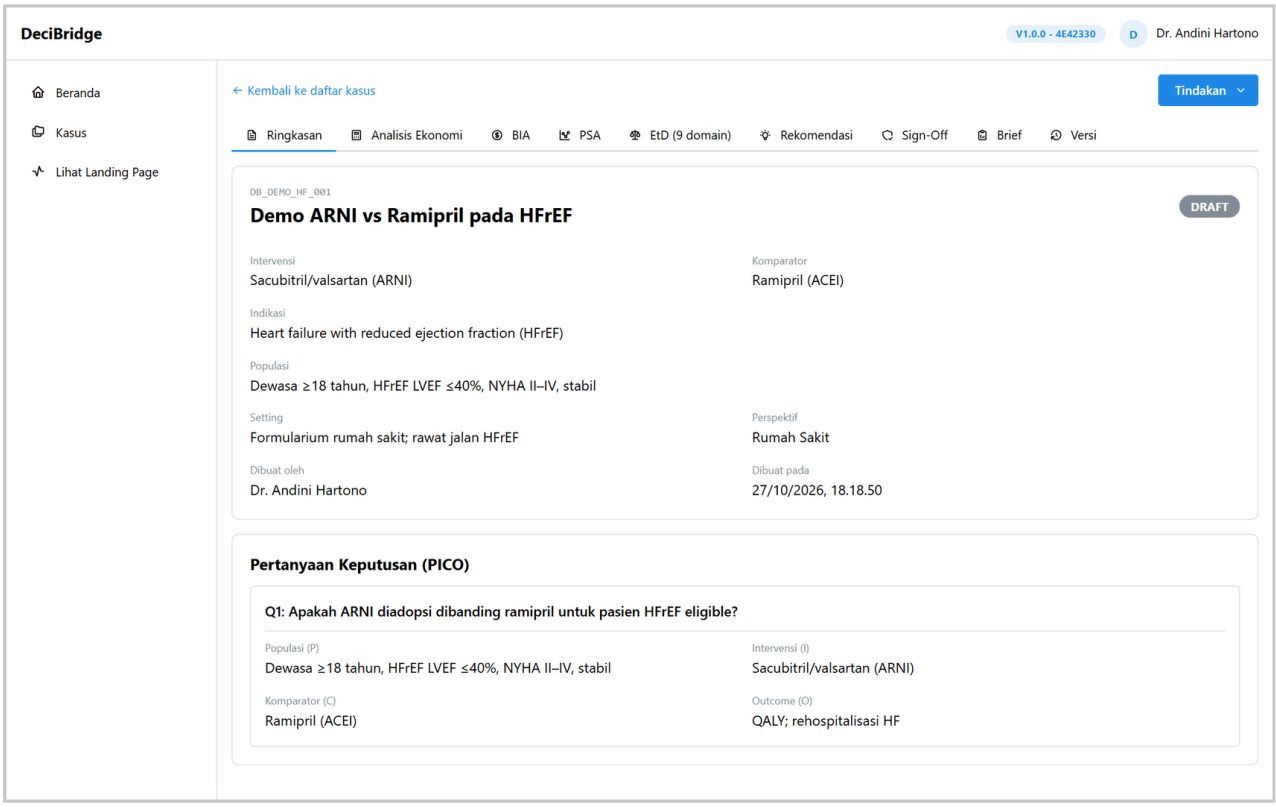
Gambar 4. Langkah Identitas pada pembuatan kasus.



Gambar 5. Langkah Klinis.



Gambar 6. Langkah PICO.



Gambar 7. Tab Ringkasan setelah kasus disimpan. Status kasus masih DRAFT.

3. Menu 2 - Analisis Ekonomi

Peran: Analis HTA **Langkah paket:** 11-24 (dan input BIA, langkah 25-33)

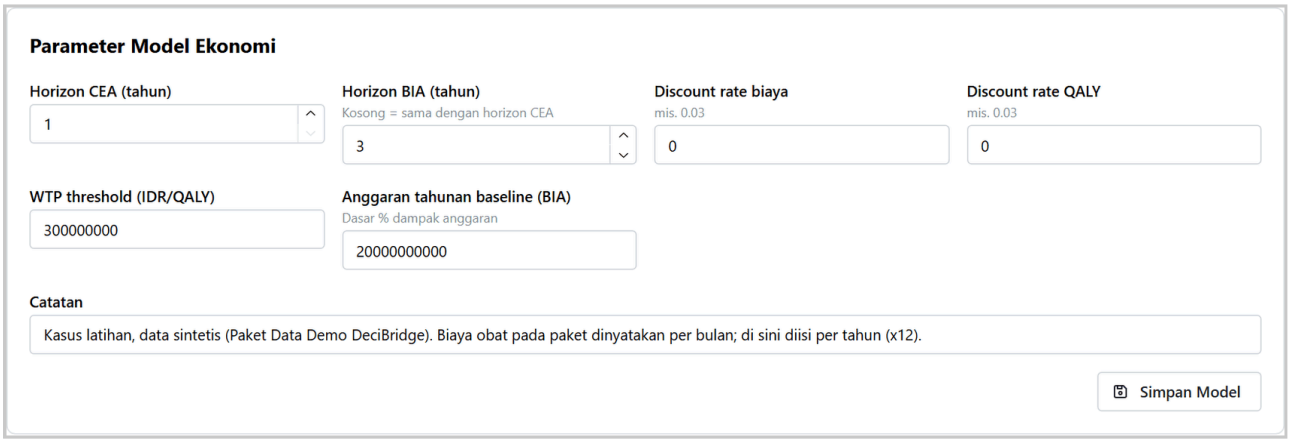
Menu ini memuat model cost-utility: beberapa pengaturan model, lalu daftar parameter untuk tiap lengan. Semua input BIA juga diketik di sini; tab BIA hanya menghitung dan menampilkan hasilnya.

3.1 Parameter model

1. Buka tab **Analisis Ekonomi**.
2. Isi kartu **Parameter Model Ekonomi** sesuai Tabel berikut.
3. Klik **Simpan Model**. Model harus tersimpan sebelum parameter dapat disimpan.

Tabel 4. Parameter model

Isian	Nilai yang diketik	Langkah	Keterangan
Horizon CEA (tahun)	`1`	9	Horizon analisis cost-utility
Horizon BIA (tahun)	`3`	25	Kosong berarti sama dengan horizon CEA
Discount rate biaya	`0`	21	Horizon hanya satu tahun
Discount rate QALY	`0`	22	Horizon hanya satu tahun
WTP threshold (IDR/QALY)	`300000000`	23	Rp300 juta per QALY
Anggaran tahunan baseline (BIA)	`20000000000`	33	Dasar persen dampak anggaran
Catatan	Keterangan bahwa data sintetis dan biaya obat diisi per tahun	-	Bebas



Gambar 8. Kartu Parameter Model Ekonomi sebelum disimpan.

3.2 Registri parameter

Setiap parameter ditambahkan sebagai satu baris. Pada bagian **Tambah parameter** di bawah tabel, pilih **Parameter**, **Alternatif** dan **Tahun**, lalu klik **Tambah**. Baris baru muncul di tabel; isi **Nilai**, **Satuan** dan **Sumber** pada baris itu.

Tabel 5. Enam belas baris parameter: sepuluh untuk analisis ekonomi, enam untuk BIA

Parameter	Alternatif	Tahun	Nilai	Satuan	Sumber	Langkah
Biaya obat per pasien per tahun	Intervensi	Semua	`14400000`	IDR/pasien/tahun	SRC-DEMO-01 Farmasi demo	11
Biaya obat per pasien per tahun	Komparator	Semua	`1200000`	IDR/pasien/tahun	SRC-DEMO-01 Farmasi demo	12

Parameter	Alternatif	Tahun	Nilai	Satuan	Sumber	Langkah
Probabilitas kejadian / rehospitalisasi	Intervensi	Semua	`0.30`	proporsi/tahun	SRC-DEMO-02 RWE demo	13
Probabilitas kejadian / rehospitalisasi	Komparator	Semua	`0.45`	proporsi/tahun	SRC-DEMO-02 RWE demo	14
Biaya per kejadian / rawat inap	Bersama	Semua	`6000000`	IDR/event	SRC-DEMO-03 Billing demo	15
Utility dasar	Intervensi	Semua	`0.78`	utility 0-1	SRC-DEMO-04 Utility demo	16
Utility dasar	Komparator	Semua	`0.74`	utility 0-1	SRC-DEMO-04 Utility demo	17
Disutility kejadian	Bersama	Semua	`0.10`	decrement/event	SRC-DEMO-04 Utility demo	18
Biaya tambahan lain	Intervensi	Semua	`300000`	IDR/pasien/tahun	Monitoring demo	19
Biaya tambahan lain	Komparator	Semua	`200000`	IDR/pasien/tahun	Monitoring demo	20
Jumlah populasi eligible	Bersama	Tahun 1	`200`	pasien/tahun	SRC-DEMO-05 SIMRS demo	26
Jumlah populasi eligible	Bersama	Tahun 2	`220`	pasien/tahun	SRC-DEMO-05 SIMRS demo	27
Jumlah populasi eligible	Bersama	Tahun 3	`240`	pasien/tahun	SRC-DEMO-05 SIMRS demo	28
Uptake	Bersama	Tahun 1	`0.20`	proporsi	SRC-DEMO-06 Protokol latihan	29
Uptake	Bersama	Tahun 2	`0.35`	proporsi	SRC-DEMO-06 Protokol latihan	30
Uptake	Bersama	Tahun 3	`0.50`	proporsi	SRC-DEMO-06 Protokol latihan	31

Empat hal yang sering keliru

Biaya obat diisi per tahun. Paket menulis biaya per bulan (Rp1.200.000 dan Rp100.000), sedangkan isian dashboard adalah biaya per pasien per tahun. Kalikan 12: `14400000` dan `1200000`.

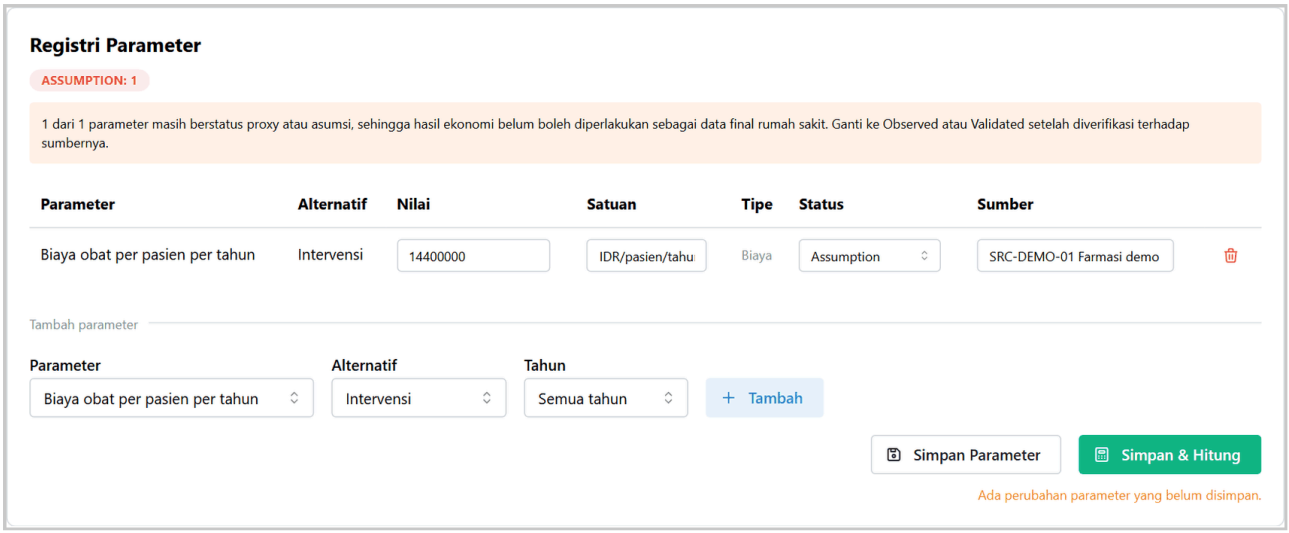
Proporsi ditulis 0-1, bukan persen. Probabilitas 30% diketik `0.30`, bukan `30`. Isian yang wajib 0-1 diberi tanda **0-1** di sisi kanan. Nilai seperti 30 ditolak saat disimpan dan barisnya ditandai merah.

Bersama berarti satu nilai dipakai kedua lengan. Biaya per kejadian dan disutility diisi sekali dengan alternatif **Bersama**, tidak perlu diketik dua kali.

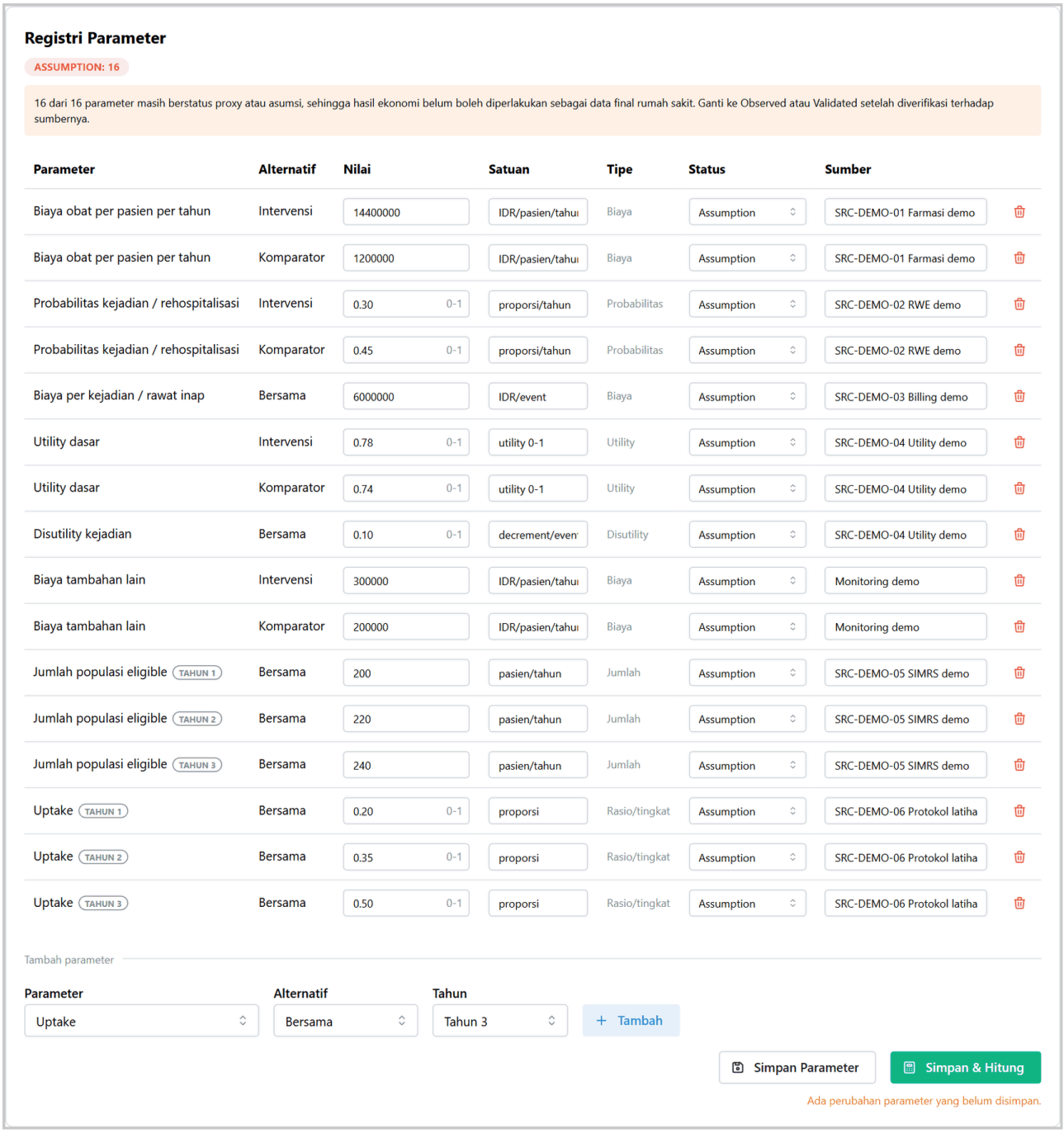
Market share tidak diisi. Lihat kotak peringatan pada Bab 4.

Status dan peringatan oranye

Kolom **Status** dibiarkan **Assumption** karena seluruh data paket adalah data sintetis. Dashboard lalu menampilkan peringatan bahwa parameter masih berstatus proxy atau asumsi. Untuk kasus latihan, peringatan itu memang seharusnya muncul.



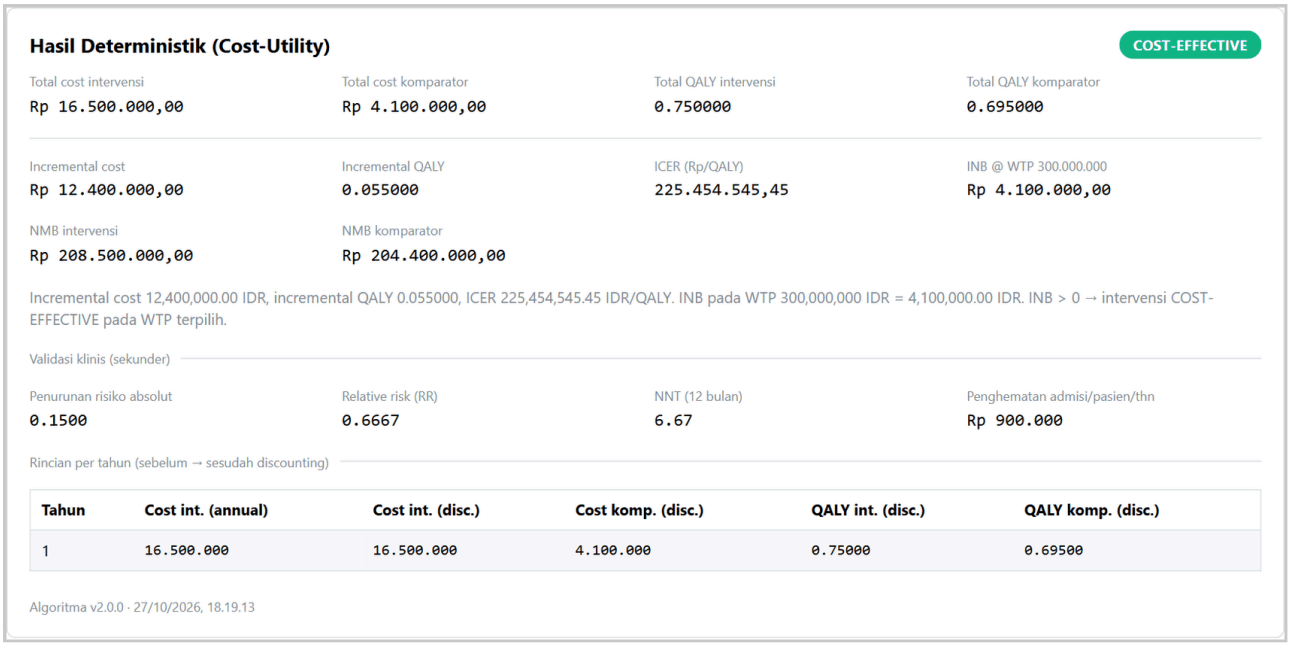
Gambar 9. Baris pertama setelah klik Tambah, dengan nilai, satuan dan sumber terisi.



Gambar 10. Registri Parameter lengkap, sebelum disimpan.

3.3 Menyimpan dan menghitung

1. Klik **Simpan Parameter**. Bila ada baris yang ditolak, alasannya tampil di bawah isian **Nilai** baris tersebut dan tidak ada baris yang tersimpan sampai semuanya benar.
2. Klik **Hitung**. Bila masih ada perubahan yang belum disimpan, tombol itu berbunyi **Simpan & Hitung** dan mengerjakan keduanya.
3. Kartu **Hasil Deterministik (Cost-Utility)** muncul di bagian atas.



Gambar 11. Hasil deterministik kasus latihan.

Cocokkan dengan kunci (langkah 24)

Total cost Rp16.500.000 vs Rp4.100.000; QALY 0,750 vs 0,695.

Incremental cost Rp12.400.000; incremental QALY 0,055; ICER Rp225.454.545,45 per QALY; INB Rp4.100.000.

ICER berada di bawah WTP Rp300 juta dan INB positif, sehingga label hasilnya COST-EFFECTIVE. Paket menegaskan bahwa keputusan tidak berhenti di sini: lanjutkan ke BIA dan PSA.

4. Menu 3 - BIA

Peran: Analis HTA **Langkah paket:** 25-34

BIA menghitung tambahan beban anggaran rumah sakit per tahun, setelah dikurangi penghematan dari kejadian yang dicegah (cost offset). Inputnya sudah diketik di menu Analisis Ekonomi: **Horizon BIA** dan **Anggaran tahunan baseline** pada parameter model, serta **Jumlah populasi eligible** dan **Uptake** untuk Tahun 1 sampai Tahun 3 pada registri parameter.

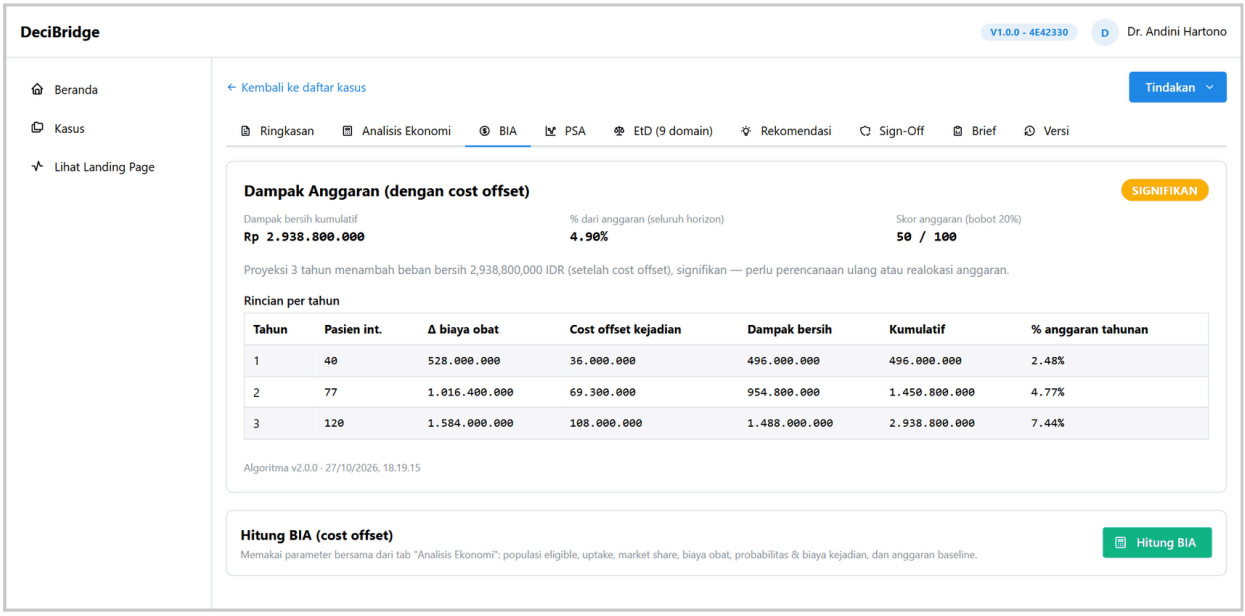
Baris per tahun

Pilihan **Tahun 1**, **Tahun 2** dan **Tahun 3** pada **Tambah parameter** baru tersedia setelah **Horizon BIA** diisi 3. Baris per tahun diberi label TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3 di tabel.

Market share baseline (langkah 32): jangan diisi

Paket menulis market share baseline ARNI = 0, artinya ARNI belum dipakai. Parameter **Market share** di dashboard bermakna lain: pengali jumlah pasien (pasien = eligible x uptake x market share) yang bernilai 1 bila tidak diisi. Mengisinya dengan 0 membuat jumlah pasien, dan seluruh BIA, menjadi nol.

1. Buka tab **BIA**.
2. Klik **Hitung BIA**.
3. Kartu **Dampak Anggaran (dengan cost offset)** menampilkan rincian per tahun.



Gambar 12. Hasil BIA tiga tahun.

Tabel 6. Hasil BIA dibanding kunci (langkah 34)

Periode	Pasien ARNI	Dampak bersih	% anggaran	Kunci instruktur	Status
Tahun 1	40	Rp496.000.000	2,48%	Rp496.000.000	Sesuai
Tahun 2	77	Rp954.800.000	4,77%	Rp954.800.000	Sesuai
Tahun 3	120	Rp1.488.000.000	7,44%	Rp1.488.000.000	Sesuai
Kumulatif	-	Rp2.938.800.000	4,90%	Rp2.938.800.000	Sesuai

Persen anggaran pada baris kumulatif dihitung terhadap anggaran tiga tahun. Label **SIGNIFIKAN** dan **Skor anggaran** pada kartu dipakai lagi di menu Rekomendasi. Pesan paket untuk bagian ini: intervensi dapat tampak cost-effective tetapi tetap menambah anggaran, sehingga keterjangkauan harus dibahas tersendiri.

5. Menu 4 - PSA

Peran: Analis HTA **Langkah paket:** 35-40

PSA mengulang perhitungan ribuan kali dengan parameter yang diambil acak dari distribusinya, untuk melihat seberapa yakin hasil cost-effective itu. Ada dua bagian: mengatur distribusi tiap parameter, lalu menjalankan simulasinya.

5.1 Mengatur distribusi (langkah 37-39)

Kartu **Distribusi Parameter PSA** memuat sepuluh parameter yang disampel. Pada kasus baru semuanya berstatus **Tetap (tidak disampel)**. Untuk tiap baris, pilih **Distribusi**, lalu isi salah satu: kolom **SE / SD**, atau **Parameter 1** dan **Parameter 2** secara langsung.

Tabel 7. Distribusi sesuai sheet 05_PSA paket

Baris	Distribusi	Yang diketik	Terisi otomatis
Biaya obat (Intervensi, Komparator); Biaya per kejadian; Biaya tambahan lain (Intervensi, Komparator)	Gamma	SE / SD: `10%`	shape 100; scale = nilai dasar / 100
Probabilitas kejadian - Intervensi	Beta	Parameter 1: `60` ; Parameter 2: `140`	SE / SD 0.032323
Probabilitas kejadian - Komparator	Beta	Parameter 1: `90` ; Parameter 2: `110`	SE / SD 0.0350905
Utility dasar - Intervensi	Beta	SE / SD: `0,06`	alpha 36.4; beta 10.2666666667
Utility dasar - Komparator	Beta	SE / SD: `0,06`	alpha 38.8088888889; beta 13.6355555556
Disutility kejadian	Beta	SE / SD: `0,03`	alpha 9.9; beta 89.1

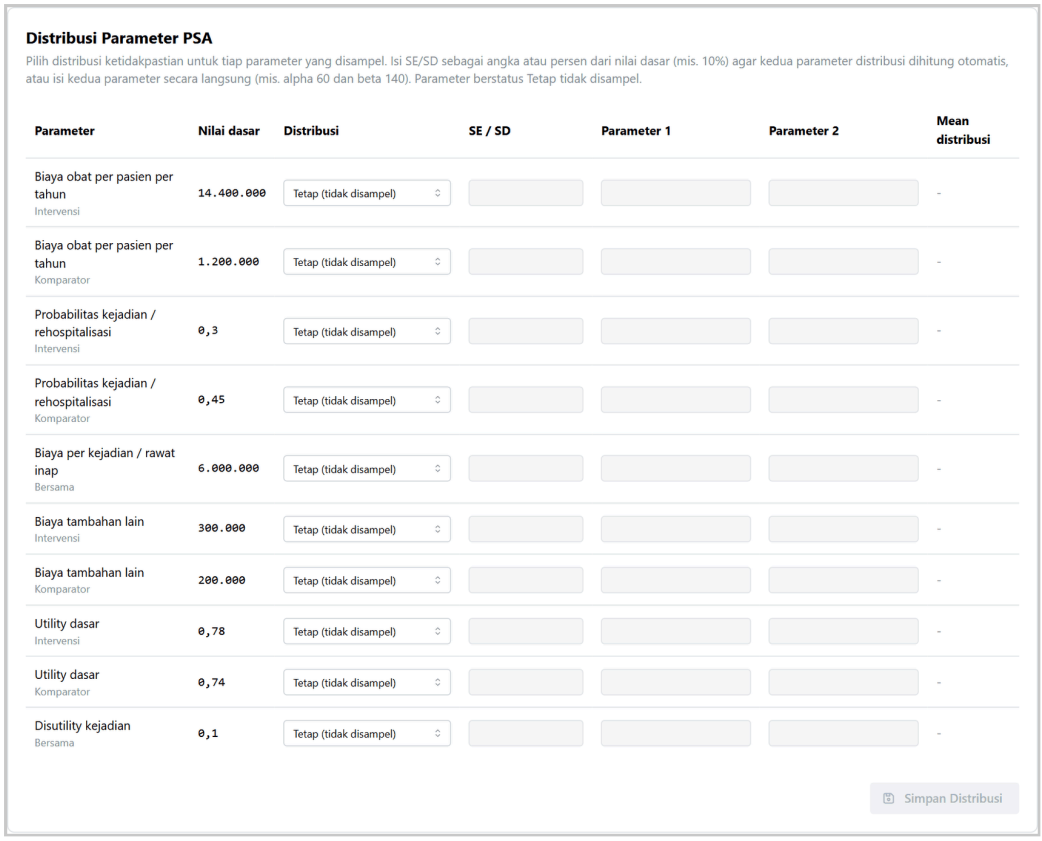
1. Buka tab **PSA** dan gulir ke kartu **Distribusi Parameter PSA**.
2. Isi kesepuluh baris sesuai Tabel di atas.
3. Periksa kolom **Mean distribusi**: nilainya harus sama dengan **Nilai dasar**.
4. Klik **Simpan Distribusi**.

Mengapa mengetik 10% dan bukan angka SE dari paket

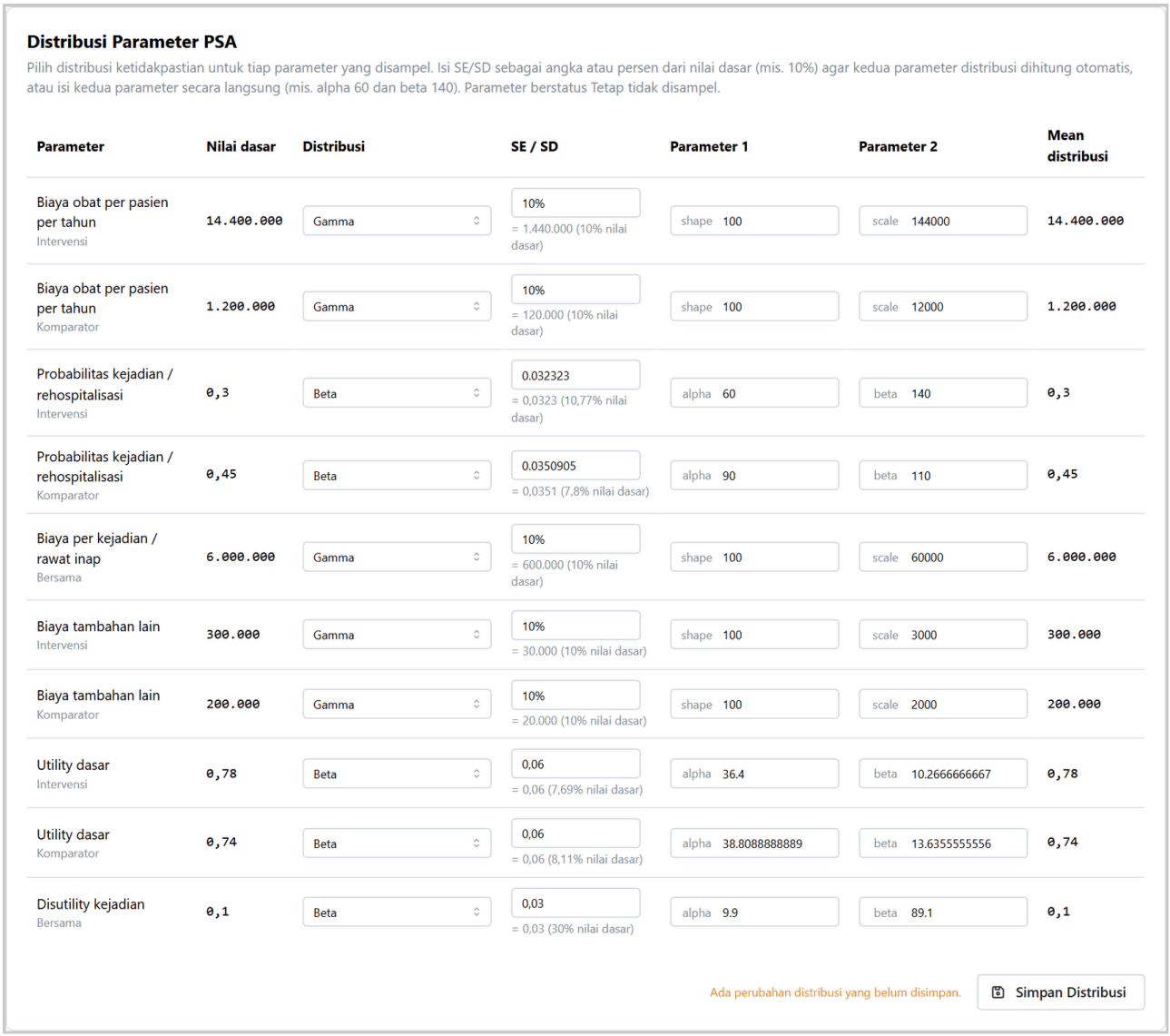
Paket menulis SE biaya obat per bulan (120.000 untuk ARNI), sedangkan nilai dasar di dashboard per tahun. Mengetik 120000 berarti SE hanya 0,83% dari nilai dasar. Mengetik `10%` selalu benar karena dihitung dari nilai dasar yang tersimpan.

Baris kecil di bawah isian SE / SD menampilkan nilai yang terbaca, misalnya "= 1.440.000 (10% nilai dasar)". Bacalah baris itu: titik adalah tanda desimal, sehingga `600.000` terbaca sebagai 600.

Beta hanya tersedia untuk probabilitas, utility dan disutility. Gamma dan Log-normal hanya tersedia untuk biaya.



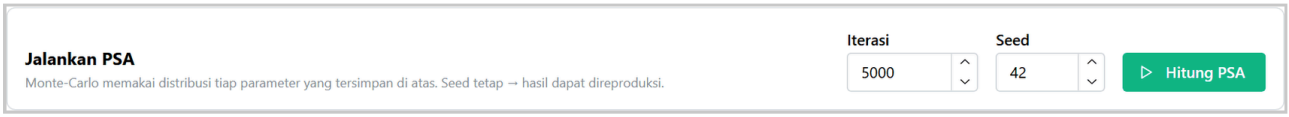
Gambar 13. Kartu distribusi pada kasus baru: semua parameter masih Tetap.



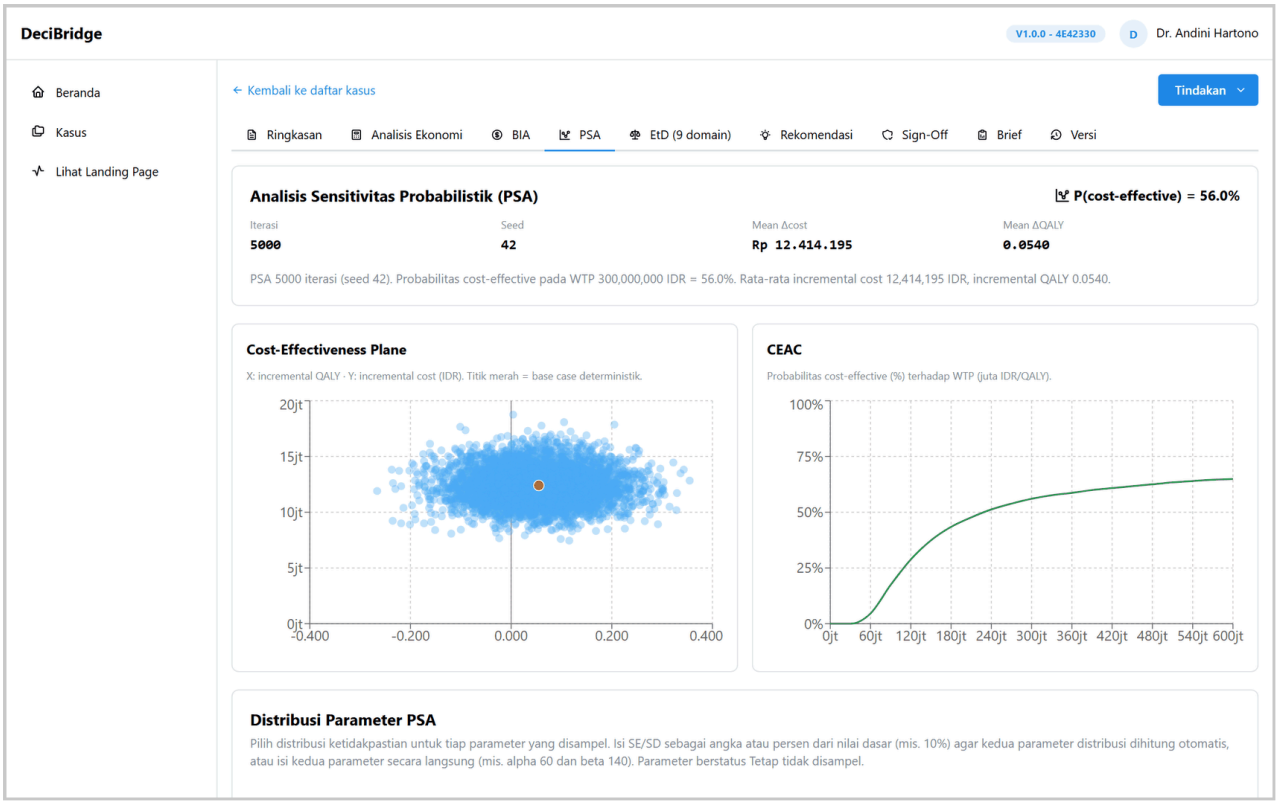
Gambar 14. Kesepuluh distribusi terisi, sebelum disimpan.

5.2 Menjalankan PSA (langkah 35, 36 dan 40)

1. Pada kartu **Jalankan PSA**, isi **Iterasi** `5000` dan **Seed** `42`.
2. Klik **Hitung PSA**. Tombol ini tidak aktif selama ada perubahan distribusi yang belum disimpan.
3. Ringkasan hasil, bidang cost-effectiveness dan kurva CEAC tampil di bagian atas tab.



Gambar 15. Pengaturan iterasi dan seed.



Gambar 16. Hasil PSA: ringkasan, bidang cost-effectiveness, dan CEAC.

Tabel 8. Hasil PSA dibanding kunci

Keluaran	Dashboard	Kunci instruktur	Status
Probabilitas cost-effective pada WTP Rp300 juta	56,02%	56,34%	Dalam toleransi
Rata-rata incremental cost	Rp12.414.195	Rp12.407.194	Dalam toleransi
Rata-rata incremental QALY	0,0540	0,0546	Dalam toleransi

Angka PSA tidak harus persis sama dengan kunci, karena pembangkit bilangan acak dashboard berbeda dari yang dipakai menyusun paket. Paket sendiri menyebut selisih beberapa poin masih wajar. Yang harus sama adalah input, arah dan tafsirannya: hasil deterministik tampak menguntungkan, tetapi peluang cost-effective hanya sekitar 56%. Dengan seed yang sama, dashboard selalu memberi angka yang sama.

Bila parameter diubah setelah PSA dijalankan

Tab PSA menampilkan peringatan **Hasil PSA ini tidak lagi sesuai input**. Jalankan ulang PSA. Contohnya ada pada latihan revisi di Bab 10.

6. Menu 5 - EtD

Peran: Analis HTA (referensi), lalu Anggota KFT (penilaian) **Langkah paket:** 41-49

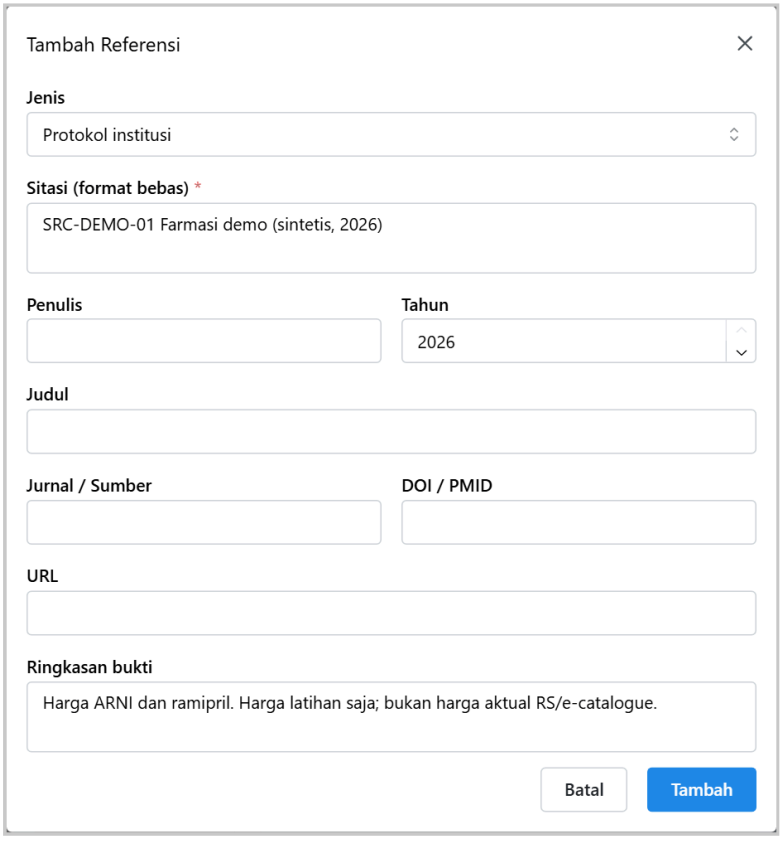
Evidence-to-Decision (EtD) menimbang bukti pada sembilan domain GRADE. Analis HTA menyiapkan daftar referensi; Anggota KFT memberi penilaian untuk tiap domain. Analis HTA dapat melihat penilaian tetapi tidak dapat mengisinya.

6.1 Referensi (Analis HTA)

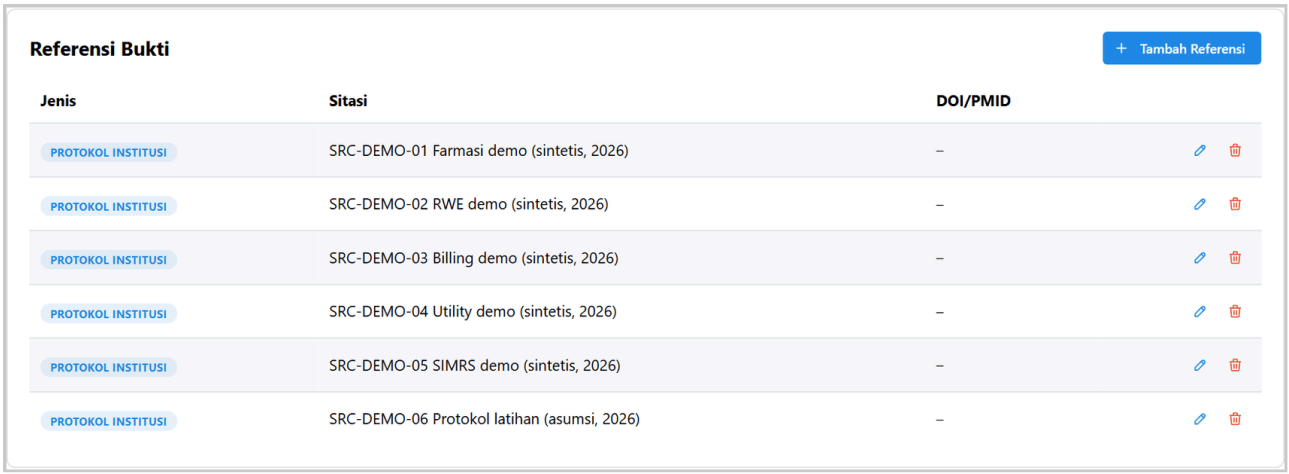
1. Buka tab **EtD (9 domain)**. Pada kartu **Referensi Bukti**, klik **Tambah Referensi**.
2. Pilih **Jenis**, isi **Sitasi (format bebas)**, **Tahun** dan **Ringkasan bukti**, lalu klik **Tambah**.
3. Ulangi untuk keenam sumber pada sheet 12_SOURCE_REGISTER paket.

Tabel 9. Enam referensi kasus latihan (jenis: Protokol institusi, tahun 2026)

Sitasi	Ringkasan bukti
SRC-DEMO-01 Farmasi demo (sintetis, 2026)	Harga ARNI dan ramipril. Harga latihan saja; bukan harga aktual RS/e-catalogue.
SRC-DEMO-02 RWE demo (sintetis, 2026)	Probabilitas rehospitalisasi 0,30 vs 0,45 per tahun. Bukan data pasien nyata.
SRC-DEMO-03 Billing demo (sintetis, 2026)	Biaya rehospitalisasi Rp6.000.000/event. Bukan tarif aktual.
SRC-DEMO-04 Utility demo (sintetis, 2026)	Utility 0,78 dan 0,74; disutility 0,10. Bukan EQ-5D aktual.
SRC-DEMO-05 SIMRS demo (sintetis, 2026)	Eligible population 200/220/240 pasien/tahun. Bukan volume nyata RS.
SRC-DEMO-06 Protokol latihan (asumsi, 2026)	Perspektif, horizon, WTP, uptake, seed. Ditentukan untuk tujuan pembelajaran.



Gambar 17. Formulir Tambah Referensi.



Gambar 18. Daftar referensi setelah keenam sumber ditambahkan.

6.2 Penilaian sembilan domain (Anggota KFT)

Keluar dari akun Analis HTA dan masuk sebagai Anggota KFT. Tiap domain berupa satu pertanyaan yang dijawab pada skala lima pilihan, dari **Tidak** sampai **Ya**, ditambah **Kepastian bukti (GRADE)**, referensi pendukung, dan pertimbangan tertulis. Penilaian baru dapat disimpan bila ada minimal satu referensi atau satu pertimbangan.

Paket memberi judgement dengan istilah yang berbeda untuk tiap domain dan meminta pengguna memilih opsi dashboard yang paling dekat. Tabel berikut adalah padanan yang dipakai dalam panduan ini. Kepastian diisi **Sedang** pada semua domain, mengikuti satu-satunya penilaian kepastian pada paket (Certainty of evidence: Moderate).

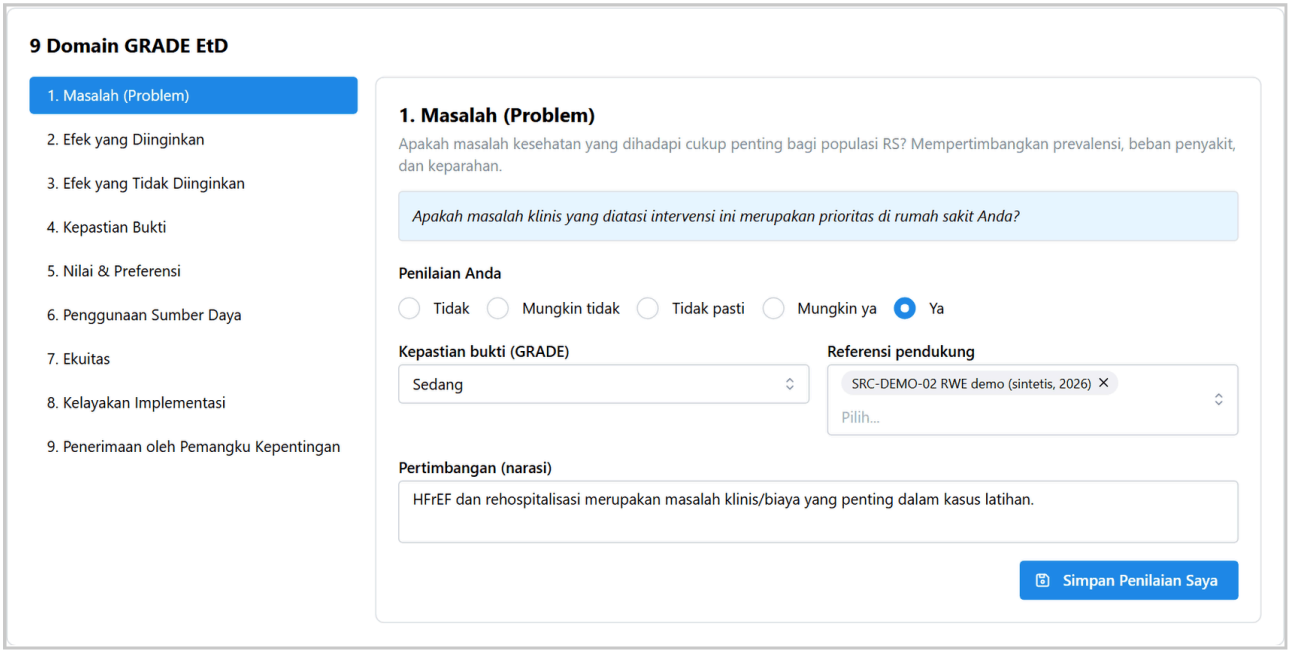
Tabel 10. Padanan judgement paket (sheet 06_ETD) ke pilihan dashboard

Domain di dashboard	Judgement paket	Pilihan	Referensi	Pertimbangan (narasi)
1. Masalah (Problem)	High	**Ya**	SRC-DEMO-02	HFrEF dan rehospitalisasi merupakan masalah klinis/biaya yang penting dalam kasus latihan.
2. Efek yang Diinginkan	Favorable	**Mungkin ya**	SRC-DEMO-02, SRC-DEMO-04	Intervensi menurunkan event dan meningkatkan QALY dibanding komparator.
3. Efek yang Tidak Diinginkan	Acceptable with monitoring	**Mungkin ya**	-	Risiko dalam latihan dianggap dapat dikelola dengan pemantauan.
4. Kepastian Bukti	Moderate	**Mungkin ya**	SRC-DEMO-02	Masih ada ketidakpastian/residual confounding walaupun arah manfaat favorable.
5. Nilai & Preferensi	Probably important	**Mungkin ya**	-	Outcome dianggap penting bagi pasien, namun variasi preferensi dapat terjadi.
6. Penggunaan Sumber Daya	Moderate concern	**Tidak pasti**	SRC-DEMO-01, SRC-DEMO-03	Value for money favorable pada WTP demo, tetapi affordability meningkat.
7. Ekuitas	Neutral / potential concern	**Tidak pasti**	-	Jika diadopsi tanpa kriteria, akses dapat dipengaruhi keterbatasan anggaran.
8. Kelayakan Implementasi	Feasible with criteria	**Mungkin ya**	-	Implementasi mungkin dilakukan dengan restriction dan monitoring.
9. Penerimaan oleh Pemangku Kepentingan	Mixed to favorable	**Mungkin ya**	-	Penerimaan mungkin berbeda antar stakeholder karena biaya.

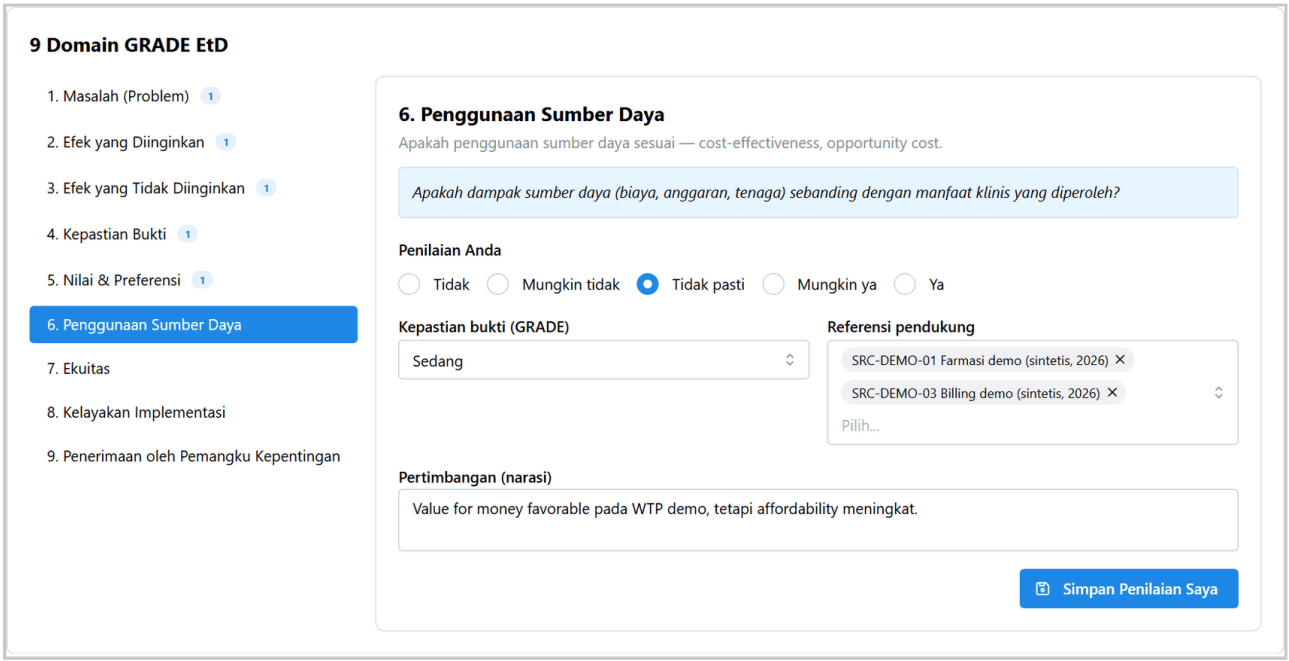
Padanan ini adalah pertimbangan, bukan kunci

Paket tidak menentukan pilihan mana pada skala lima pilihan yang setara dengan "Favorable" atau "Moderate concern". Kelompok yang menimbang berbeda boleh memilih berbeda, asal alasannya ditulis pada **Pertimbangan**. Pilihan yang berbeda mengubah Skor Kekuatan Bukti dan dapat mengubah rekomendasi.

1. Buka tab **EtD (9 domain)** dan pilih domain pada daftar di sisi kiri.
2. Pilih **Penilaian Anda**, lalu **Kepastian bukti (GRADE)**.
3. Pilih **Referensi pendukung** bila ada, dan tulis **Pertimbangan (narasi)**.
4. Klik **Simpan Penilaian Saya**. Angka kecil di samping nama domain menunjukkan jumlah suara yang sudah masuk.
5. Ulangi sampai kesembilan domain terisi.



Gambar 19. Penilaian domain 1, sebelum disimpan.



Gambar 20. Penilaian domain 6 (Penggunaan Sumber Daya).



Gambar 21. Ringkasan EtD setelah kesembilan domain terisi.

Cara skor dihitung

Skor satu domain adalah rata-rata nilai penilaian (Tidak 0, Mungkin tidak 25, Tidak pasti 50, Mungkin ya 75, Ya 100) dan nilai kepastian (Sangat rendah 25, Rendah 50, Sedang 75, Tinggi 100). **Skor Kekuatan Bukti** adalah rata-rata kesembilan domain.

Dengan penilaian pada Tabel di atas, skornya 73,61 dari 100.

Selama belum semua domain terisi, skor diberi tanda **Sementara** dan rekomendasi belum dapat dihitung.

7. Menu 6 - Rekomendasi

Peran: Sekretaris KFT (kriteria akses), Analis HTA (menghitung), lalu Anggota KFT (keputusan final) **Langkah paket:** 50-53

Menu ini menggabungkan bukti EtD, cost-effectiveness, dampak anggaran dan kriteria akses menjadi satu rekomendasi berwarna yang dihitung sistem. Di bawahnya, KFT mencatat keputusannya sendiri beserta alasan. Warna sistem adalah bahan pertimbangan; keputusan KFT yang ditandatangani.

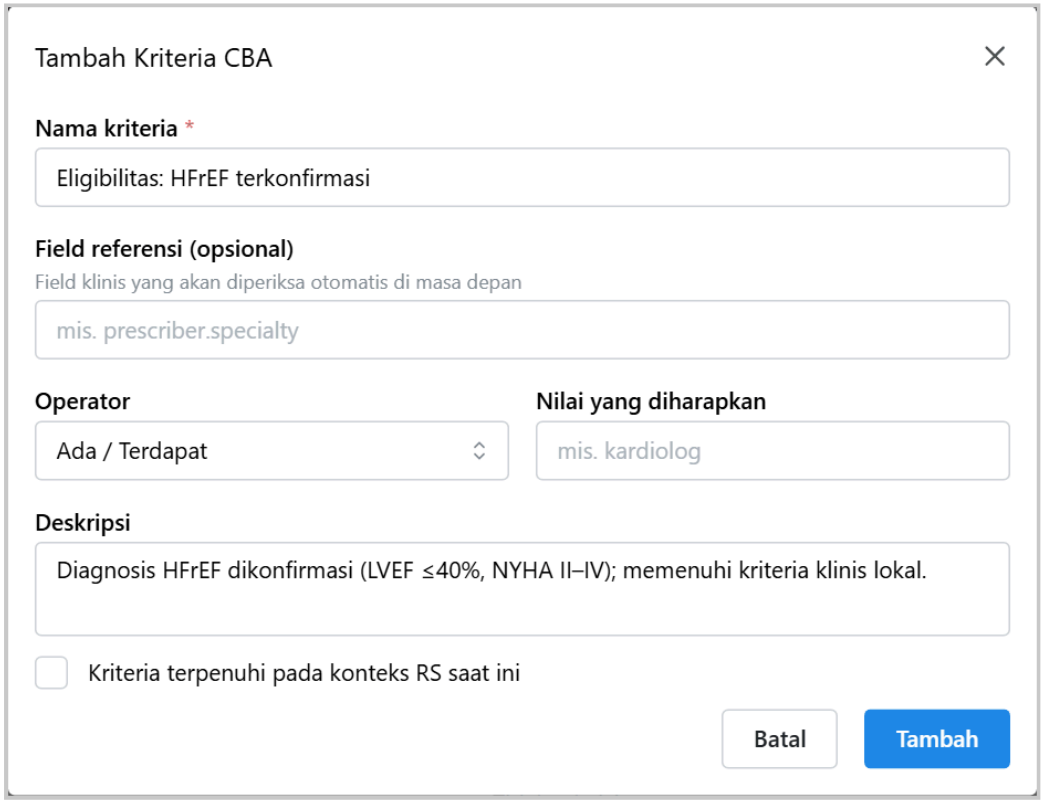
7.1 Kriteria akses (langkah 52)

Kriteria akses adalah syarat penggunaan obat bila disetujui. Sekretaris KFT, Analis HTA dan Ketua KFT dapat mengisinya.

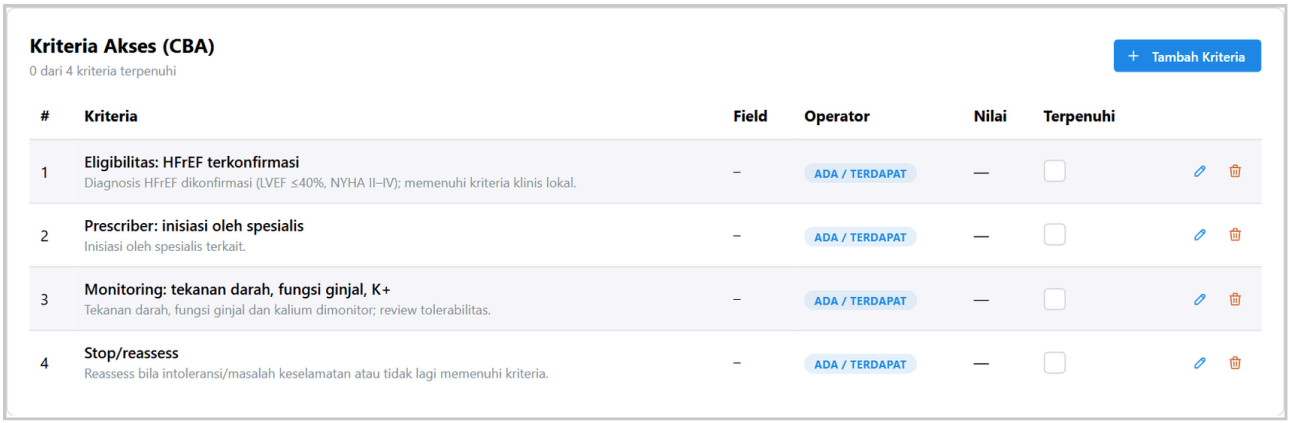
1. Buka tab **Rekomendasi**. Pada kartu **Kriteria Akses (CBA)**, klik **Tambah Kriteria**.
2. Isi **Nama kriteria** dan **Deskripsi**. Isian lain boleh dibiarkan.
3. Biarkan kotak **Kriteria terpenuhi pada konteks RS saat ini** tidak dicentang, lalu klik **Tambah**.
4. Ulangi untuk keempat kriteria pada sheet 07_REKOMENDASI paket.

Tabel 11. Empat kriteria akses kasus latihan

Nama kriteria	Deskripsi
Eligibilitas: HFrEF terkonfirmasi	Diagnosis HFrEF dikonfirmasi (LVEF ≤40%, NYHA II–IV); memenuhi kriteria klinis lokal.
Prescriber: inisiasi oleh spesialis	Inisiasi oleh spesialis terkait.
Monitoring: tekanan darah, fungsi ginjal, K+	Tekanan darah, fungsi ginjal dan kalium dimonitor; review tolerabilitas.
Stop/reassess	Reassess bila intoleransi/masalah keselamatan atau tidak lagi memenuhi kriteria.



Gambar 22. Formulir Tambah Kriteria CBA.



Gambar 23. Empat kriteria, belum ada yang dicentang terpenuhi.

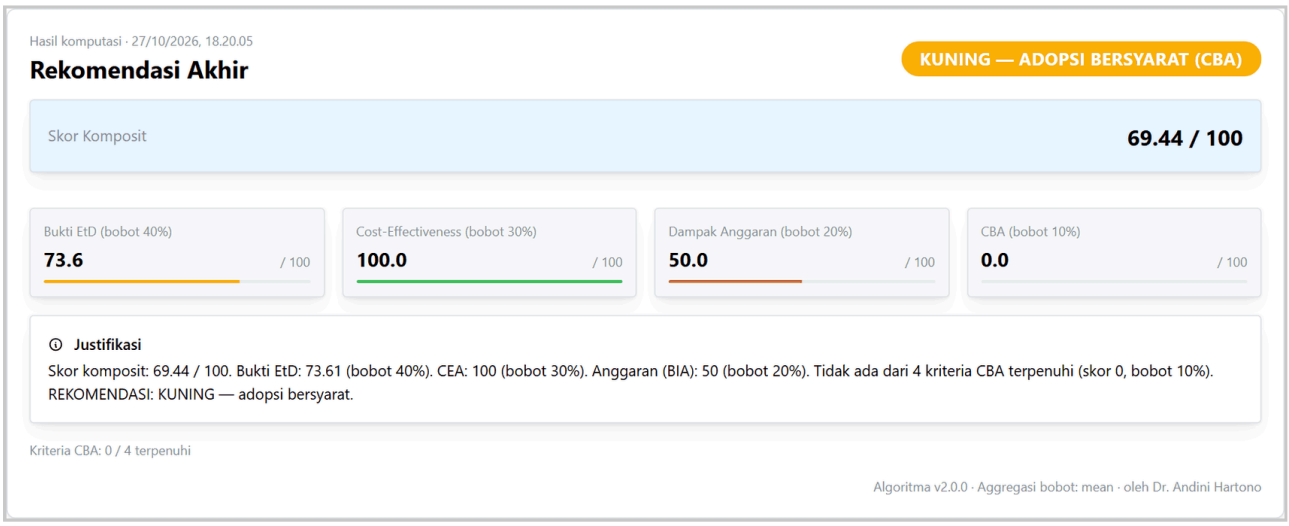
Mengapa kotak "terpenuhi" tidak dicentang

Sistem membaca kriteria yang belum terpenuhi sebagai syarat yang masih harus dipenuhi, sehingga adopsinya bersyarat. Pada paket, pemantauan dan alur kerja masih harus ditetapkan (sheet 06_ETD, kolom Action needed: "Specify monitoring", "Define workflow"), jadi keempat kriteria ini adalah syarat adopsi, bukan hal yang sudah berjalan.

Centang hanya syarat yang memang sudah berjalan di rumah sakit. Bila keempatnya dicentang pada kasus ini, sistem menganggap tidak ada syarat tersisa: skor komposit menjadi 79,44 dan hasilnya HIJAU - Adopsi Tanpa Syarat.

7.2 Menghitung rekomendasi sistem

1. Masuk sebagai Analis HTA dan buka tab **Rekomendasi**.
2. Klik **Hitung Rekomendasi**.
3. Kartu **Rekomendasi Akhir** menampilkan warna, skor komposit, keempat komponen, dan kalimat **Justifikasi**.



Gambar 24. Rekomendasi sistem untuk kasus latihan.

Tabel 12. Komponen rekomendasi sistem

Komponen	Bobot	Skor	Berasal dari
Bukti EtD	40%	73,61	Skor Kekuatan Bukti (Bab 6)
Cost-effectiveness	30%	100,00	Hasil deterministik (Bab 3)
Dampak anggaran	20%	50,00	Skor anggaran BIA (Bab 4)
Kriteria akses (CBA)	10%	0,00	0 dari 4 kriteria terpenuhi

Komponen	Bobot	Skor	Berasal dari
Skor komposit		**69,44**	**KUNING - Adopsi Bersyarat (CBA)**

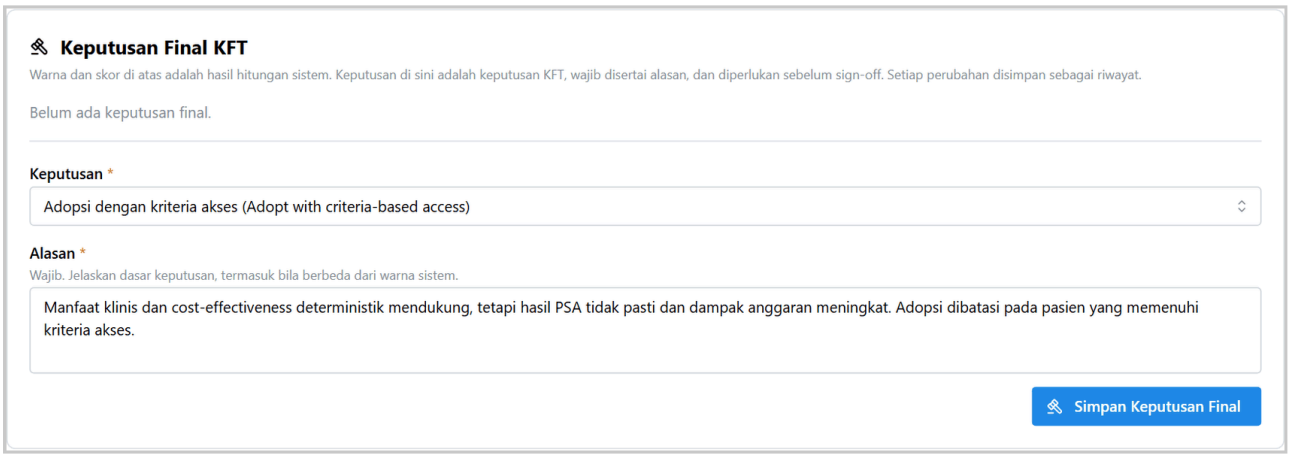
7.3 Keputusan Final KFT (langkah 50, 51 dan 53)

Paket meminta jenis keputusan dan alasan terintegrasi diisi manusia. Kartu **Keputusan Final KFT** di bawah rekomendasi sistem menampung keduanya. Kartu ini diisi oleh Anggota KFT atau Ketua KFT, wajib disertai alasan, dan menjadi syarat sign-off. Setiap perubahan disimpan sebagai riwayat; keputusan lama tidak pernah ditimpa.

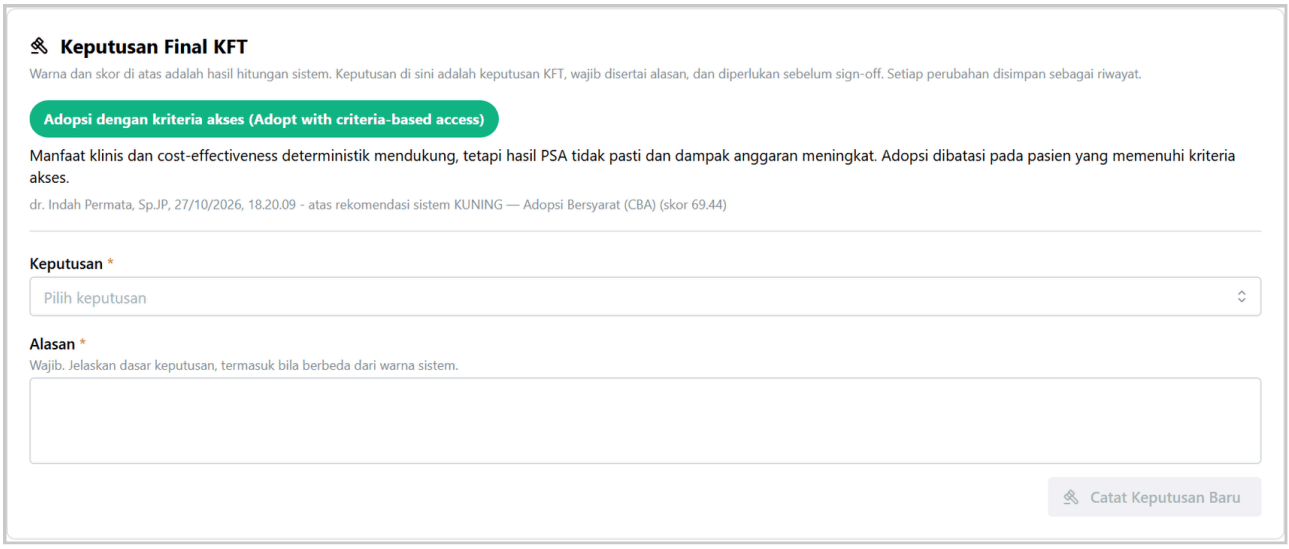
1. Masuk sebagai Anggota KFT dan buka tab **Rekomendasi**.
2. Pada kartu **Keputusan Final KFT**, pilih **Keputusan**: `Adopsi dengan kriteria akses (Adopt with criteria-based access)`.
3. Tulis **Alasan** yang memadukan seluruh menu, tidak hanya "ICER di bawah WTP".
4. Klik **Simpan Keputusan Final**. Keputusan, alasan, nama pencatat, waktu, dan warna rekomendasi sistem yang menjadi dasarnya tampil pada kartu.

Tabel 13. Keputusan Final KFT kasus latihan (paket langkah 50 dan 53)

Isian	Nilai pada kasus latihan
Keputusan	Adopsi dengan kriteria akses (Adopt with criteria-based access)
Alasan	Manfaat klinis dan cost-effectiveness deterministik mendukung, tetapi hasil PSA tidak pasti dan dampak anggaran meningkat. Adopsi dibatasi pada pasien yang memenuhi kriteria akses.



Gambar 25. Kartu Keputusan Final KFT sebelum disimpan.



Gambar 26. Keputusan Final KFT tersimpan, di samping warna dan skor sistem.

Warna sistem dan keputusan KFT

Lima jenis keputusan tersedia: Adopt, Adopt with criteria-based access, Defer pending additional evidence, Do not adopt, dan Reassess after price negotiation. KFT boleh memilih keputusan yang berbeda dari warna sistem, asal alasannya ditulis.

Hasil **KUNING - Adopsi Bersyarat (CBA)** sepadan dengan keputusan latihan pada paket, "Adopt with criteria-based access": manfaat dan cost-effectiveness mendukung, tetapi dampak anggaran bermakna dan penggunaannya dibatasi kriteria.

Bila rekomendasi dihitung ulang setelah keputusan dicatat, kartu meminta keputusan dicatat ulang atas rekomendasi terbaru sebelum sign-off.

Target populasi (langkah 51) tidak diisi di sini: tercatat pada Ringkasan dan pertanyaan PICO, dan dicetak pada brief sebagai Populasi target.

Yang perlu diketahui

Hasil PSA tidak masuk ke skor komposit. Skor cost-effectiveness hanya memakai hasil deterministik, sehingga ketidakpastian sekitar 56% ditimbang KFT dalam Keputusan Final KFT dan alasannya.

Bobot Domain EtD pada tab ini boleh diisi Anggota KFT, tetapi sesuai keterangan di layar hanya menjadi informasi dan tidak mengubah skor.

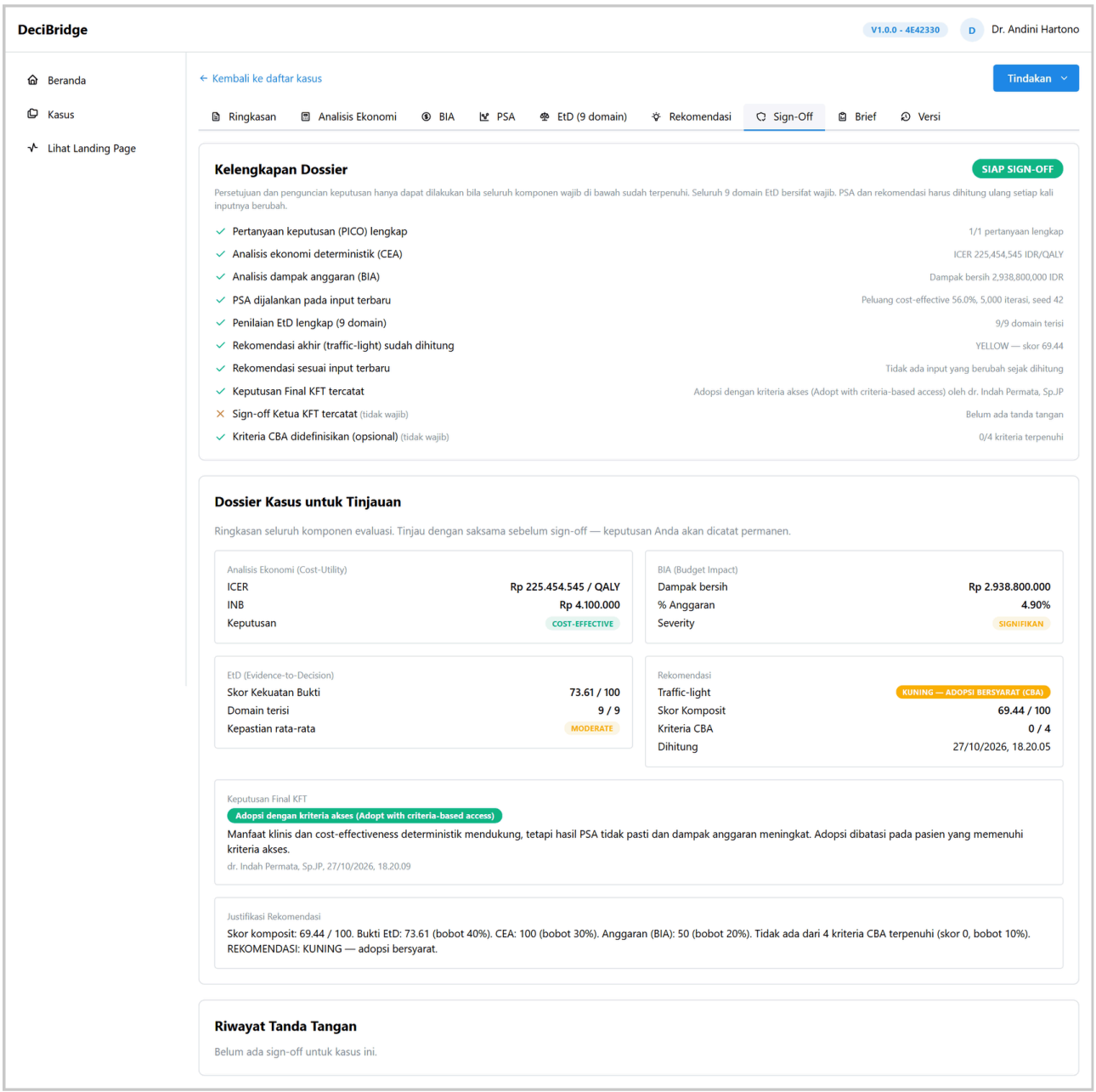
8. Menu 7 - Sign-Off

Peran: Analis HTA (mengajukan), lalu Ketua KFT (menandatangani) **Langkah paket:** 54-55

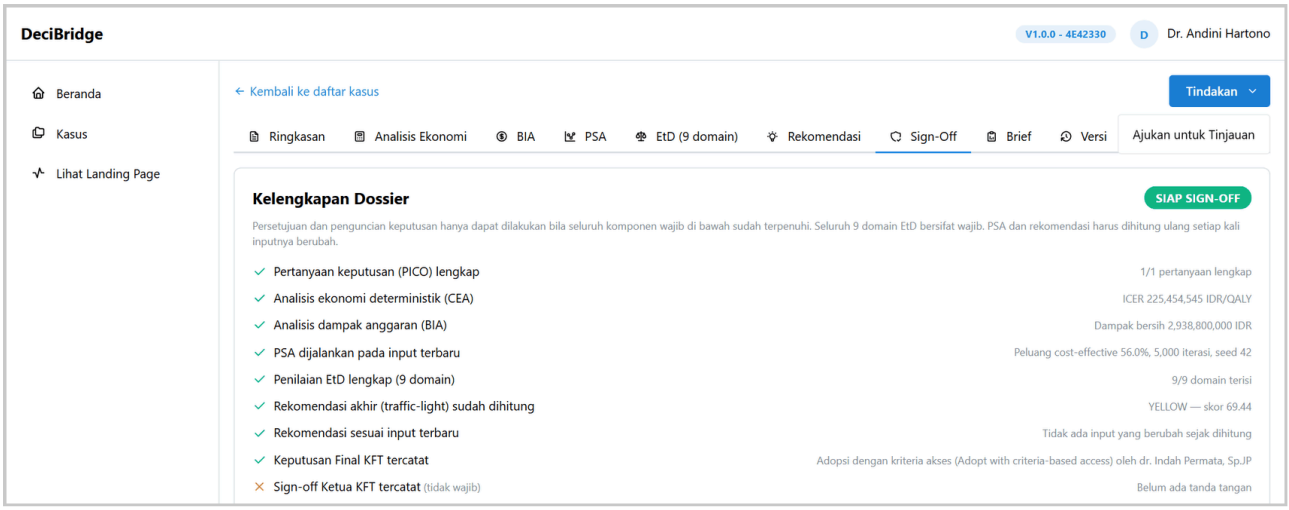
Sign-off adalah persetujuan resmi Ketua KFT atas Keputusan Final KFT. Sebelum itu, Analis HTA memeriksa kelengkapan dossier dan mengajukan kasus untuk ditinjau.

8.1 Memeriksa dan mengajukan (Analis HTA)

1. Buka tab **Sign-Off**. Kartu **Kelengkapan Dossier** harus bertanda **SIAP SIGN-OFF**, dengan semua butir wajib tercentang.
2. Periksa kartu **Dossier Kasus untuk Tinjauan**: angkanya harus sama dengan tab asalnya, dan Keputusan Final KFT tercantum.
3. Klik **Tindakan** di kanan atas, lalu **Ajukan untuk Tinjauan**. Status kasus menjadi Dalam Tinjauan.



Gambar 27. Kelengkapan dossier dan ringkasannya, dilihat Analis HTA.



Gambar 28. Menu Tindakan dengan pilihan Ajukan untuk Tinjauan.

Bandingkan dengan checklist paket (sheet 08_SIGN_OFF)

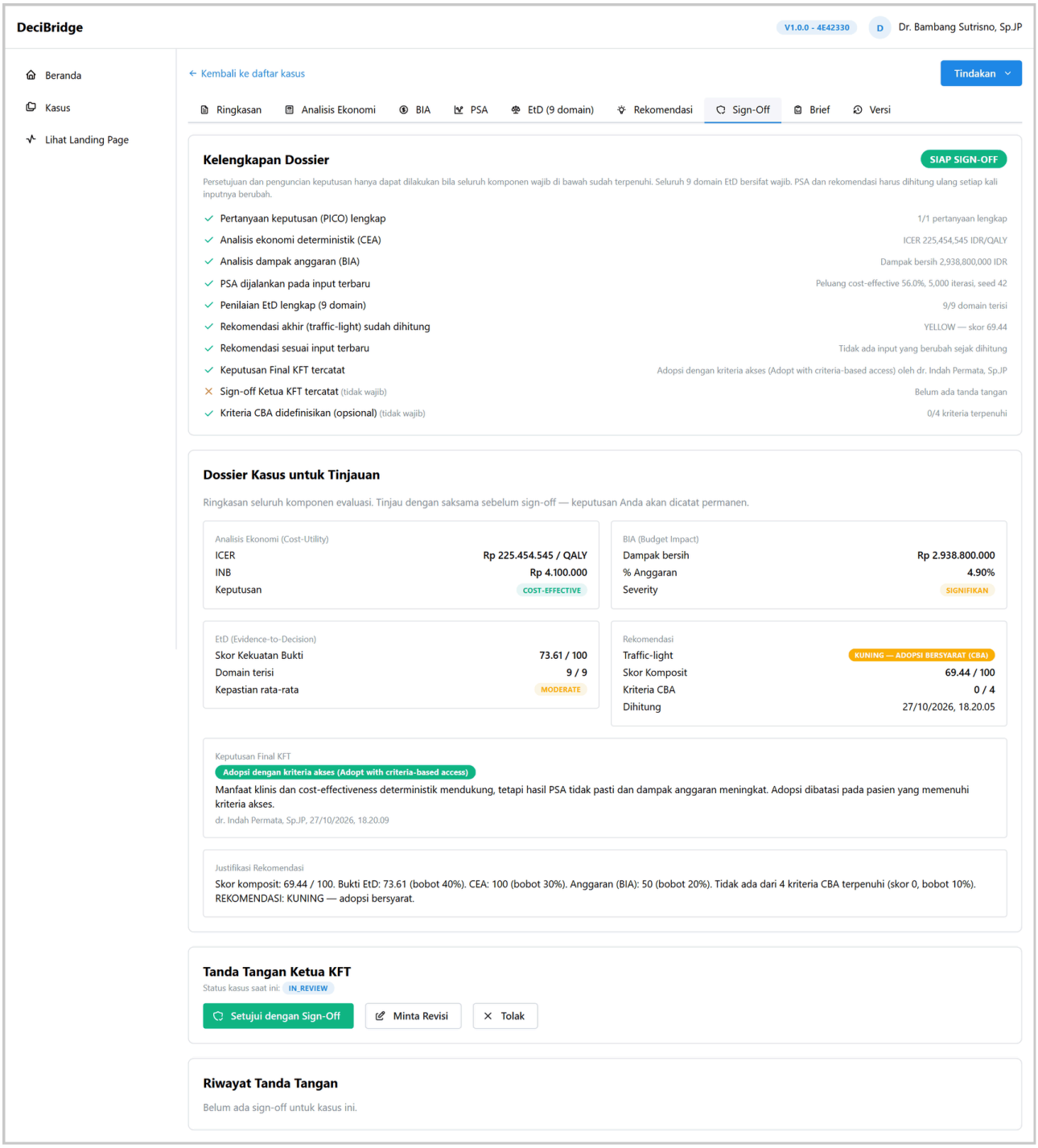
Kelengkapan Dossier memeriksa PICO, analisis ekonomi, BIA, **PSA yang dijalankan pada input terbaru**, sembilan domain EtD, rekomendasi, **rekomendasi yang masih sesuai input**, **Keputusan Final KFT**, sign-off dan kriteria CBA.

PSA dianggap berlaku hanya bila inputnya sama dengan input sekarang. PSA yang dijalankan sebelum 13 Oktober 2026 belum mencatat inputnya dan harus dijalankan ulang sekali.

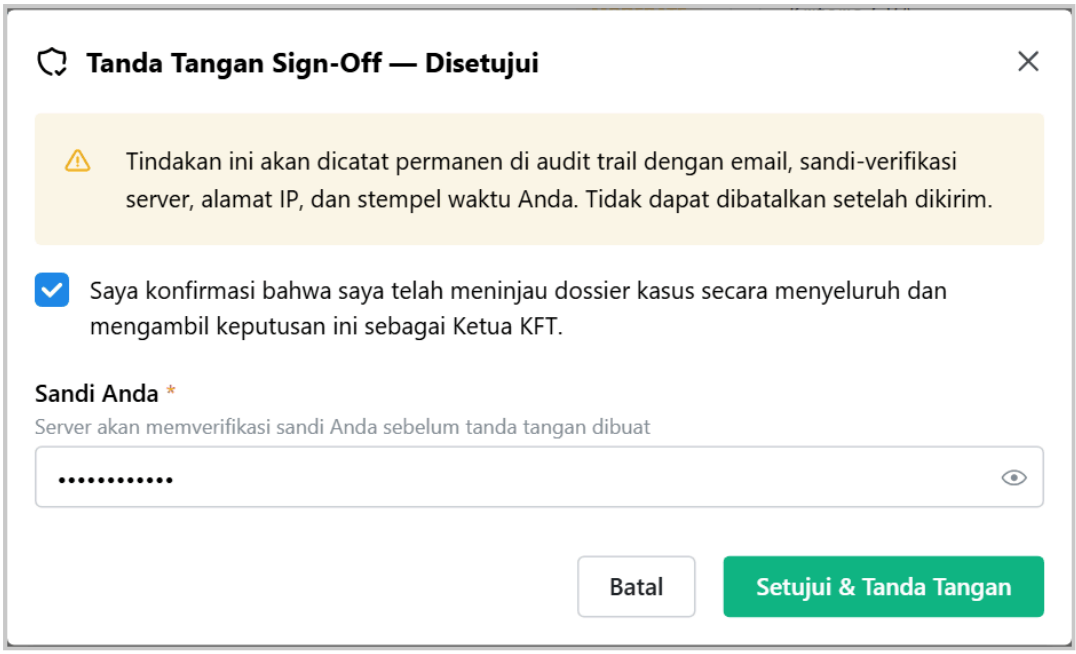
Bila ada butir wajib yang kurang, pengajuan ditolak dengan pesan **Dossier belum lengkap** beserta daftar kekurangannya, dan tombol tanda tangan Ketua KFT tidak aktif.

8.2 Menandatangani (Ketua KFT)

1. Masuk sebagai Ketua KFT dan buka tab **Sign-Off** kasus tersebut.
2. Tinjau dossier. Pada kartu **Tanda Tangan Ketua KFT**, klik **Setujui dengan Sign-Off**.
3. Centang pernyataan konfirmasi, ketik **Sandi Anda**, lalu klik **Setujui & Tanda Tangan**.
4. Status kasus menjadi Disetujui, dan tanda tangan tercatat pada **Riwayat Tanda Tangan** bersama Keputusan Final KFT yang ditandatangani.



Gambar 29. Tab Sign-Off dilihat Ketua KFT, dengan tiga pilihan keputusan.



Gambar 30. Konfirmasi dan sandi sebelum tanda tangan dicatat.



Gambar 31. Riwayat tanda tangan. Alamat IP disamarkan.

Wewenang

Hanya Ketua KFT yang melihat tombol tanda tangan. Peran lain dapat menyiapkan seluruh bukti dan draf, tetapi tidak dapat menyetujui.

Tanda tangan mengikat Keputusan Final KFT yang tercatat saat itu. Bila Ketua KFT berpendapat lain, ia mencatat keputusan baru di tab Rekomendasi lebih dulu.

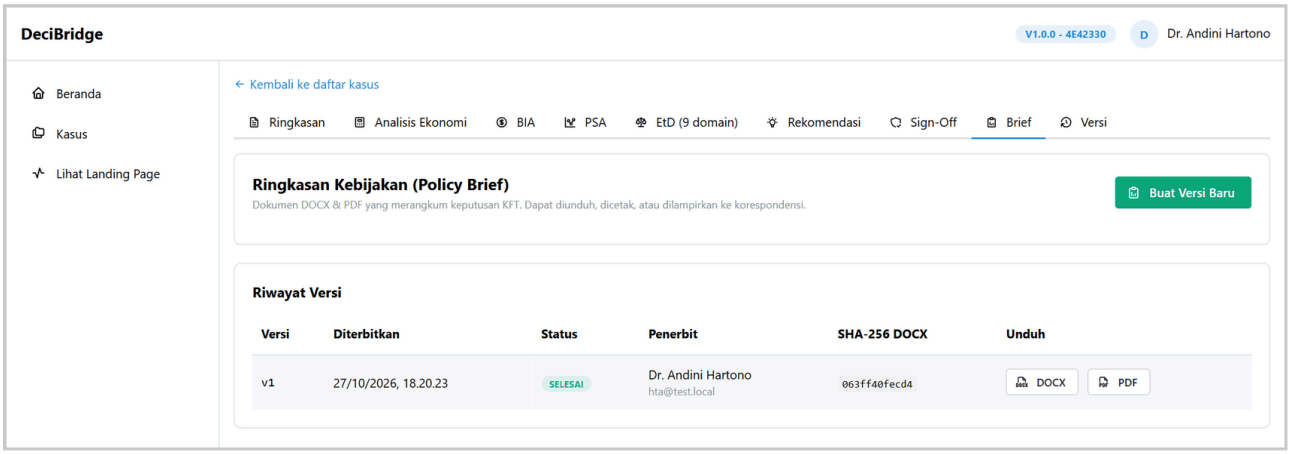
Minta Revisi dan **Tolak** pada kartu ini wajib disertai alasan dan mengembalikan kasus ke Draft.

9. Menu 8 - Brief

Peran: Analis HTA (Ketua KFT juga dapat) **Langkah paket:** 56

Brief adalah ringkasan kebijakan dalam bentuk DOCX dan PDF. Brief baru dapat diterbitkan setelah kasus berstatus Disetujui atau Terkunci.

1. Buka tab **Brief** dan klik **Terbitkan Ringkasan**. Pembuatan dokumen memakan beberapa detik.
2. Baris **v1** muncul pada **Riwayat Versi** dengan status **SELESAI**.
3. Klik **DOCX** atau **PDF** untuk mengunduh. Kolom **SHA-256 DOCX** adalah sidik jari berkas, untuk membuktikan bahwa dokumen tidak diubah.



Gambar 32. Brief versi 1 selesai diterbitkan.

Tabel 14. Isi brief versi 1, sudah dicocokkan dengan berkas yang dihasilkan

Bagian brief	Isi pada kasus latihan
Sampul	ID kasus, judul, intervensi, komparator, indikasi, populasi target, setting, perspektif, status, versi, tanggal
1. Ringkasan Eksekutif	Keputusan Final KFT (Adopsi dengan kriteria akses (Adopt with criteria-based access)) dan alasannya; lalu rekomendasi sistem KUNING - Adopsi Bersyarat (CBA), skor komposit 69,44 dan keempat komponennya
2. Pertanyaan Keputusan dan Populasi Target	Populasi target, pertanyaan keputusan, dan keempat unsur PICO
3. Analisis Efektivitas Biaya (CEA)	ICER Rp225.454.545; biaya Rp16.500.000 vs Rp4.100.000; QALY 0,7500 vs 0,6950; ambang Rp300.000.000 per QALY
4. Analisis Dampak Anggaran (BIA)	Tahun 1 Rp496.000.000; Tahun 2 Rp954.800.000; Tahun 3 Rp1.488.000.000; kumulatif Rp2.938.800.000
5. Analisis Sensitivitas Probabilistik (PSA)	5.000 iterasi, seed 42; peluang cost-effective 56,02%; rerata selisih biaya dan QALY; titik-titik CEAC
6. Evidence-to-Decision (EtD)	Tabel sembilan domain: skor, pilihan, kepastian, jumlah penilai
7. Kriteria Akses (CBA)	Empat kriteria dan status terpenuhinya
8. Daftar Referensi	Enam referensi
9. Ringkasan Audit & Tanda Tangan	Penanda tangan, keputusan, waktu

Bandingkan dengan sheet 09_BRIEF paket

Angka CEA, BIA, PSA, EtD dan rekomendasi pada brief sama dengan tab asalnya.

Brief memuat ringkasan PSA, pertanyaan keputusan, populasi target, dan Keputusan Final KFT yang ditandatangani.

Berkas brief hasil pengerjaan ini disertakan pada folder `contoh-brief`.

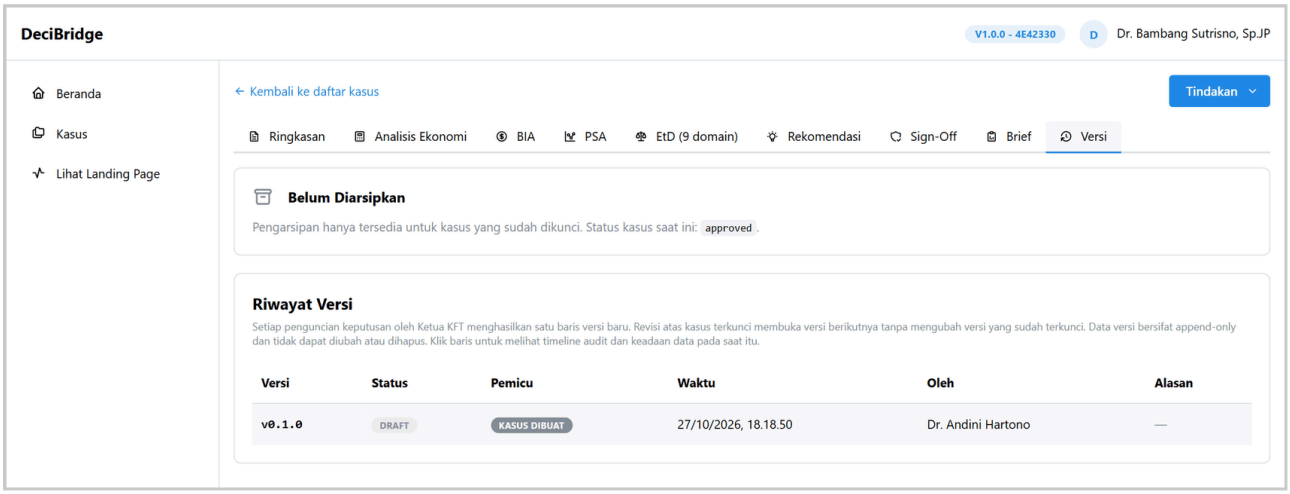
10. Menu 9 - Versi

Peran: Ketua KFT, Analis HTA, dan Anggota KFT **Langkah paket:** 55, 57-59

Menu Versi mencatat riwayat kasus. Versi dibuat oleh sistem pada tiga saat: ketika kasus dibuat (v0.1.0), ketika keputusan dikunci (v1.0, v1.1, dan seterusnya), dan ketika kasus terkunci dibuka untuk revisi (misalnya v1.1-draft, beserta alasannya). Versi yang sudah terkunci tidak pernah diubah, dan hasil perhitungan tidak pernah ditimpa.

10.1 Versi awal (langkah 57)

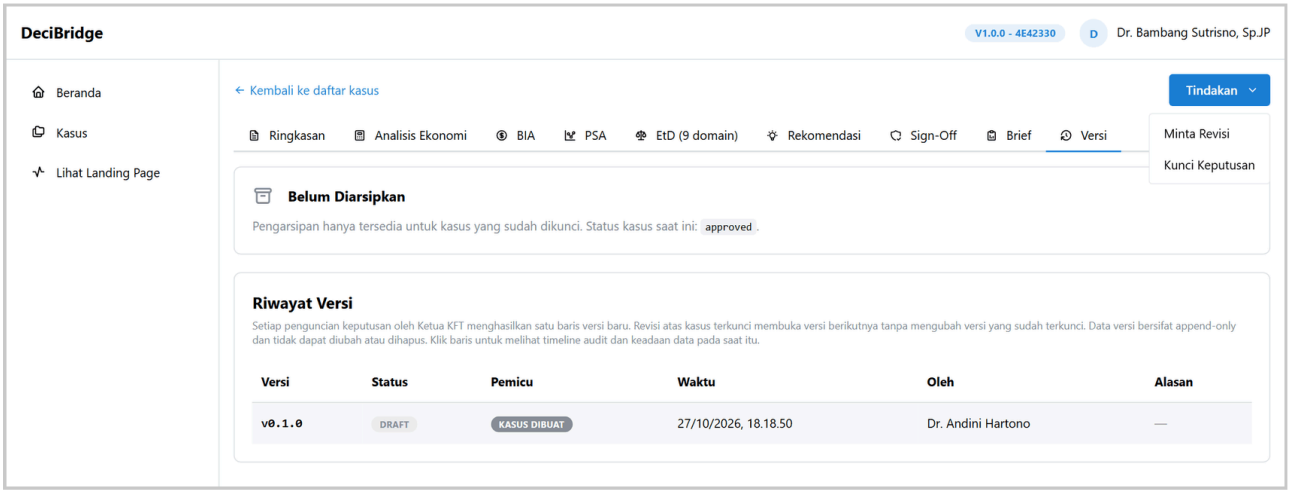
Buka tab **Versi**. Baris **v0.1.0** dengan pemicu **KASUS DIBUAT** sudah ada sejak kasus disimpan; tidak ada tombol untuk menyimpan versi secara manual.



Gambar 33. Riwayat versi sebelum keputusan dikunci.

10.2 Mengunci keputusan sebagai v1.0 (langkah 55)

1. **Ketua KFT:** klik **Tindakan**, lalu **Kunci Keputusan**. Status menjadi Terkunci dan baris **v1.0** dengan pemicu **KEPUTUSAN DIKUNCI** muncul di tab Versi.
2. Seluruh angka yang menjadi dasar keputusan dibekukan pada v1.0. Semua isian kini hanya dapat dibaca.

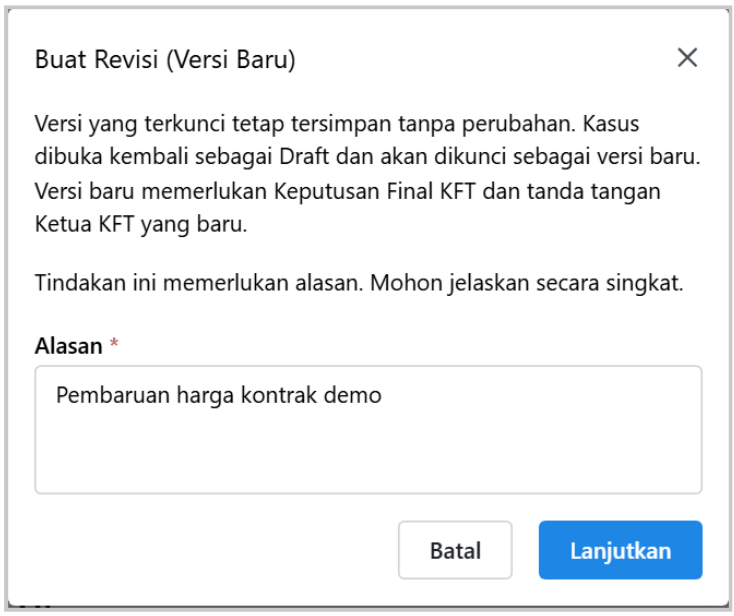


Gambar 34. Menu Tindakan Ketua KFT pada kasus yang sudah disetujui.

10.3 Latihan revisi sebagai versi baru (langkah 58-59)

Paket meminta harga ARNI diturunkan dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.100.000 per bulan, yaitu `13200000` per tahun, sebagai versi baru dengan alasan yang tercatat, tanpa mengubah versi lama. Analis HTA atau Ketua KFT dapat memulai revisi; di sini Ketua KFT.

1. **Ketua KFT:** klik **Tindakan**, lalu **Buat Revisi (Versi Baru)**. Ketik alasannya, `Pembaruan harga kontrak demo`, dan klik **Lanjutkan**. Kasus kembali ke Draft dengan keterangan **Revisi dari v1.0 sedang berjalan**; v1.0 tetap tersimpan tanpa perubahan.
2. **Analis HTA:** pada tab **Analisis Ekonomi**, ubah **Nilai** baris Biaya obat per pasien per tahun - Intervensi menjadi `13200000`, lalu klik **Simpan & Hitung**.
3. **Analis HTA:** pada tab **BIA**, klik **Hitung BIA**.
4. **Analis HTA:** pada tab **PSA**, dua peringatan muncul: hasil PSA tidak lagi sesuai input, dan mean distribusi biaya obat ARNI berbeda dari nilai dasarnya. Ketik ulang `10%` pada baris itu, klik **Simpan Distribusi**, lalu **Hitung PSA** dengan iterasi 5000 dan seed 42.
5. **Analis HTA:** pada tab **Rekomendasi**, peringatan **Rekomendasi ini tidak lagi sesuai input** muncul. Klik **Hitung Rekomendasi**.
6. **Anggota KFT:** pada kartu **Keputusan Final KFT**, catat keputusan untuk versi baru dengan **Catat Keputusan Baru**. Keputusan untuk v1.0 tetap tercantum pada riwayat.
7. **Analis HTA:** klik **Tindakan**, lalu **Ajukan untuk Tinjauan**.
8. **Ketua KFT:** pada tab **Sign-Off**, tanda tangani lagi dengan **Setujui dengan Sign-Off**. Tanda tangan untuk v1.0 tidak berlaku untuk versi baru.
9. **Analis HTA:** pada tab **Brief**, klik **Buat Versi Baru**. Brief v2 terbit; brief v1 tetap tersimpan dengan sidik jari yang berbeda.
10. **Ketua KFT:** klik **Tindakan**, lalu **Kunci Keputusan**. Versi baru terkunci sebagai **v1.1**, beserta brief v2.



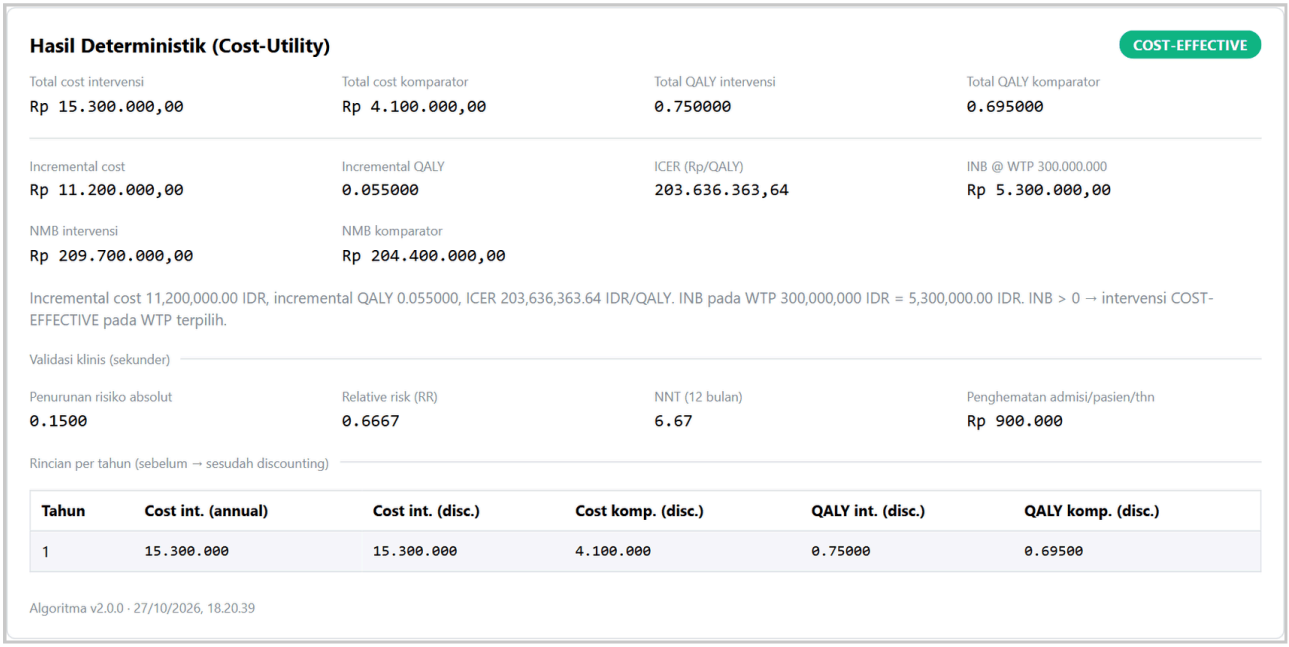
Gambar 35. Membuat revisi: penjelasan dan alasan wajib sebelum kasus dibuka kembali.



Gambar 36. Kasus kembali ke Draft dengan keterangan revisi dari v1.0.



Gambar 37. Nilai biaya obat ARNI diganti menjadi 13200000.



Gambar 38. Hasil deterministik setelah revisi harga.

Tabel 15. Hasil setelah revisi dibanding kunci

Keluaran	Dashboard	Kunci (sheet 10_VERSI, v0.2)	Status
Incremental cost	Rp11.200.000	Rp11.200.000	Sesuai
ICER per QALY	Rp203.636.363,64	Rp203.636.363,64	Sesuai
INB	Rp5.300.000	Rp5.300.000	Sesuai



Dampak Anggaran (dengan cost offset)

SIGNIFIKAN

Dampak bersih kumulatif
Rp 2.654.400.000

% dari anggaran (seluruh horizon)
4.42%

Skor anggaran (bobot 20%)
50 / 100

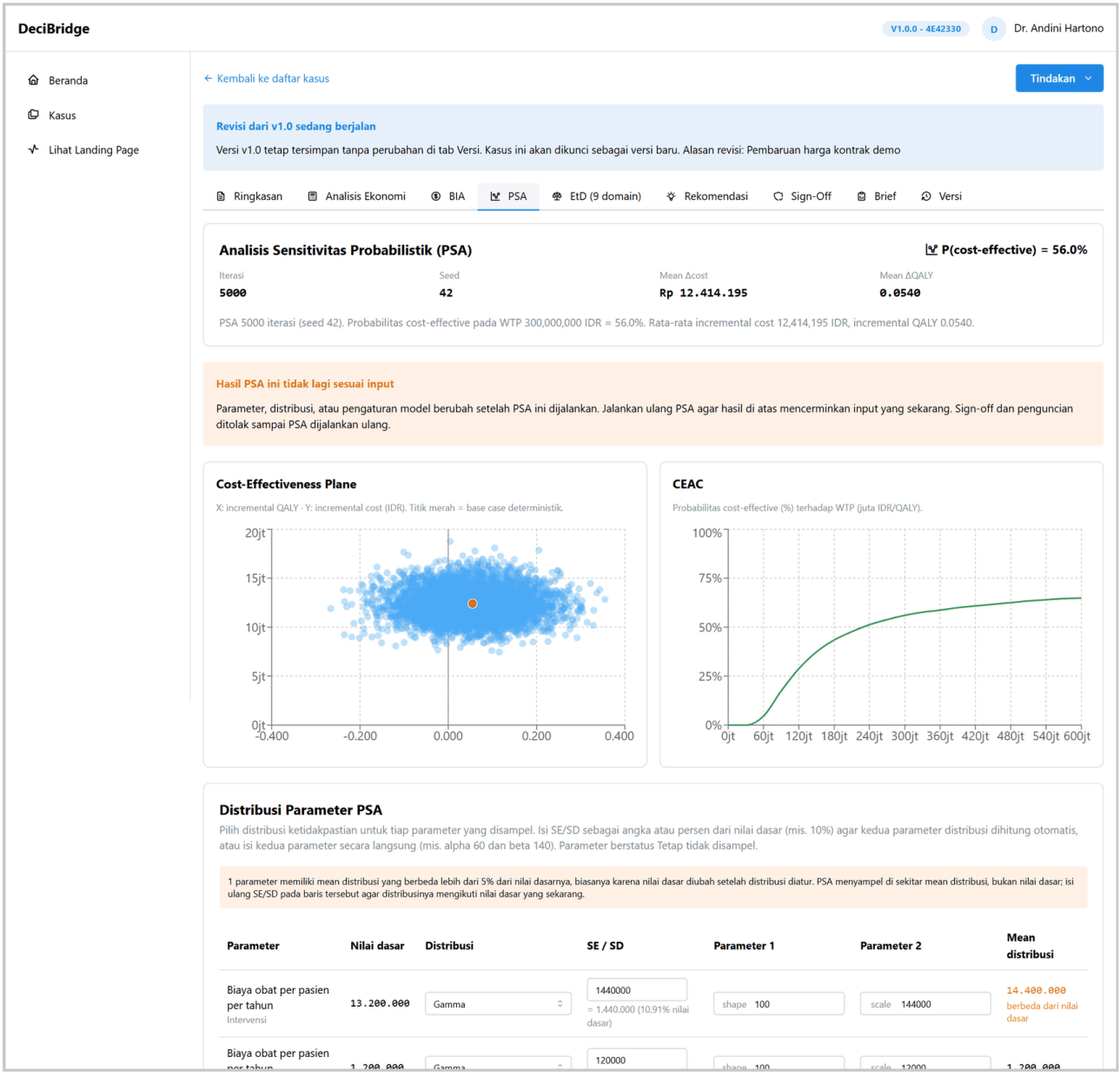
Proyeksi 3 tahun menambah beban bersih 2,654,400,000 IDR (setelah cost offset), signifikan — perlu perencanaan ulang atau realokasi anggaran.

Rincian per tahun

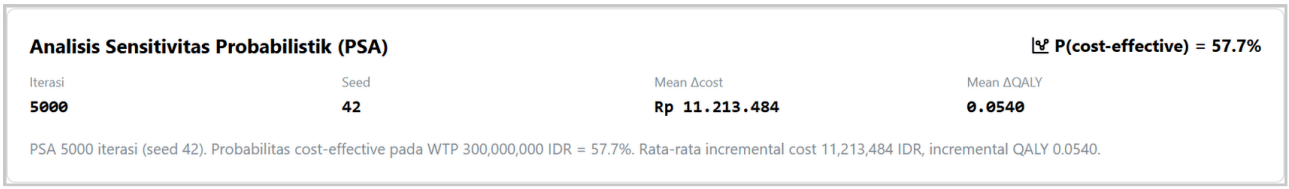
Tahun	Pasien int.	Δ biaya obat	Cost offset kejadian	Dampak bersih	Kumulatif	% anggaran tahunan
1	40	480.000.000	36.000.000	448.000.000	448.000.000	2.24%
2	77	924.000.000	69.300.000	862.400.000	1.310.400.000	4.31%
3	120	1.440.000.000	108.000.000	1.344.000.000	2.654.400.000	6.72%

Algoritma v2.0.0 · 27/10/2026, 18.20.42

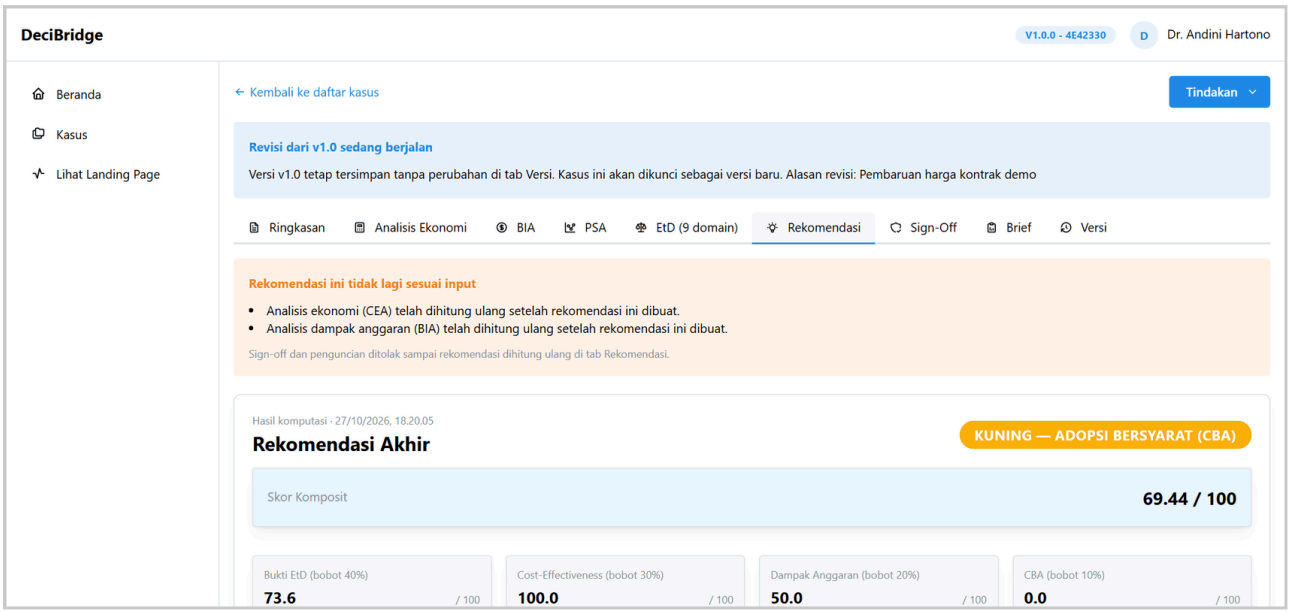
Gambar 39. BIA setelah revisi harga.



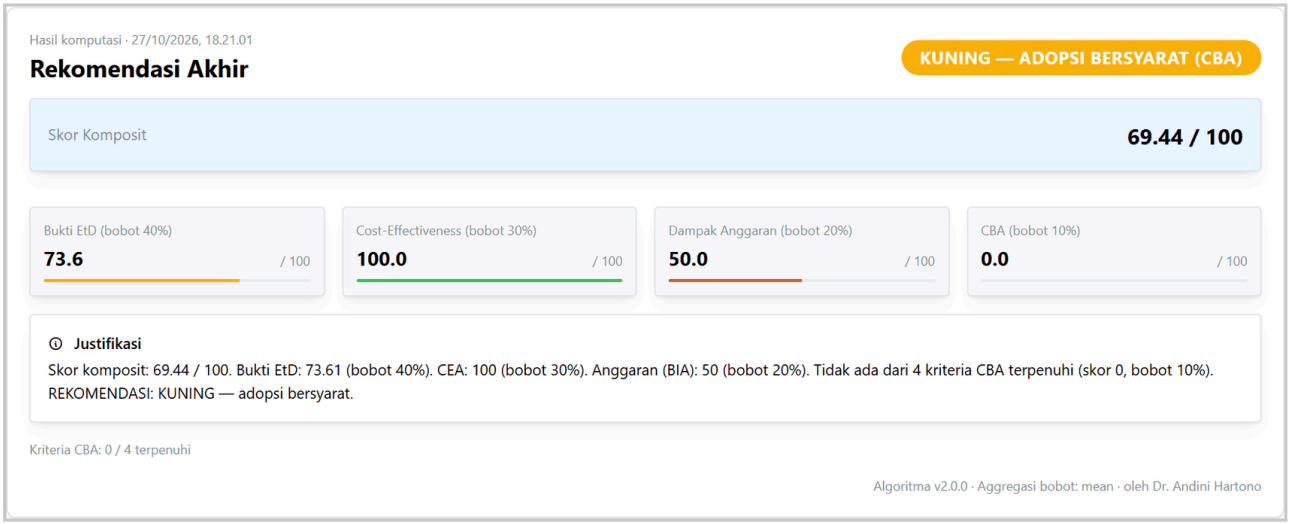
Gambar 40. Tab PSA setelah harga diubah: hasil lama ditandai tidak sesuai input, dan baris biaya obat ARNI ditandai berbeda dari nilai dasar.



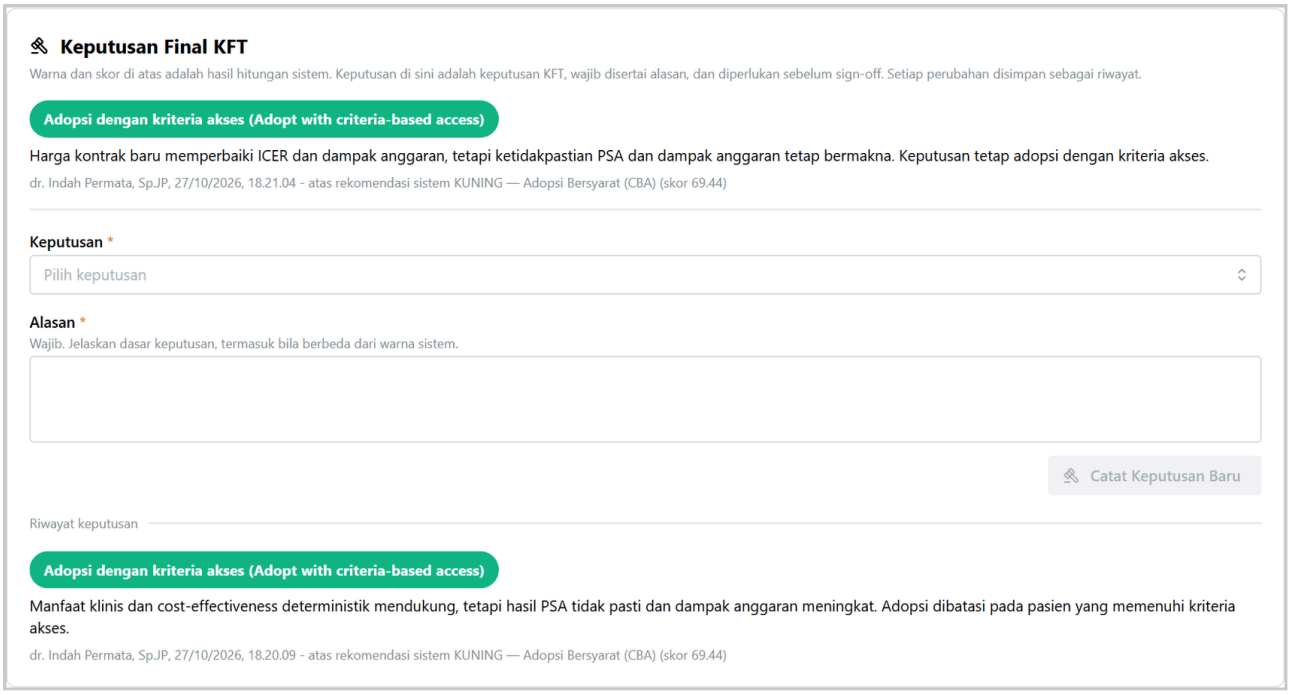
Gambar 41. PSA setelah distribusi disesuaikan dan dijalankan ulang.



Gambar 42. Tab Rekomendasi memberi tahu bahwa rekomendasi lama tidak lagi sesuai input.



Gambar 43. Rekomendasi setelah dihitung ulang.



Gambar 44. Keputusan Final KFT untuk versi baru; keputusan untuk v1.0 ada pada riwayat.

Angka setelah revisi

BIA: Tahun 1 Rp448.000.000; Tahun 2 Rp862.400.000; Tahun 3 Rp1.344.000.000; kumulatif Rp2.654.400.000.

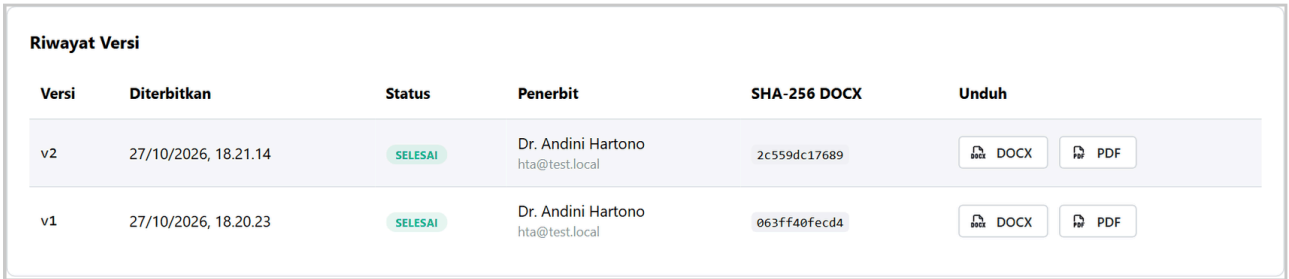
PSA: probabilitas cost-effective 57,68% (5000 iterasi, seed 42).

Rekomendasi sistem: KUNING - Adopsi Bersyarat (CBA), skor komposit 69,44. Penurunan harga memperbaiki ICER dan BIA, tetapi tidak mengubah jenis rekomendasi.

Keputusan Final KFT untuk versi baru: Adopsi dengan kriteria akses (Adopt with criteria-based access), dengan alasan: Harga kontrak baru memperbaiki ICER dan dampak anggaran, tetapi ketidakpastian PSA dan dampak anggaran tetap bermakna. Keputusan tetap adopsi dengan kriteria akses.



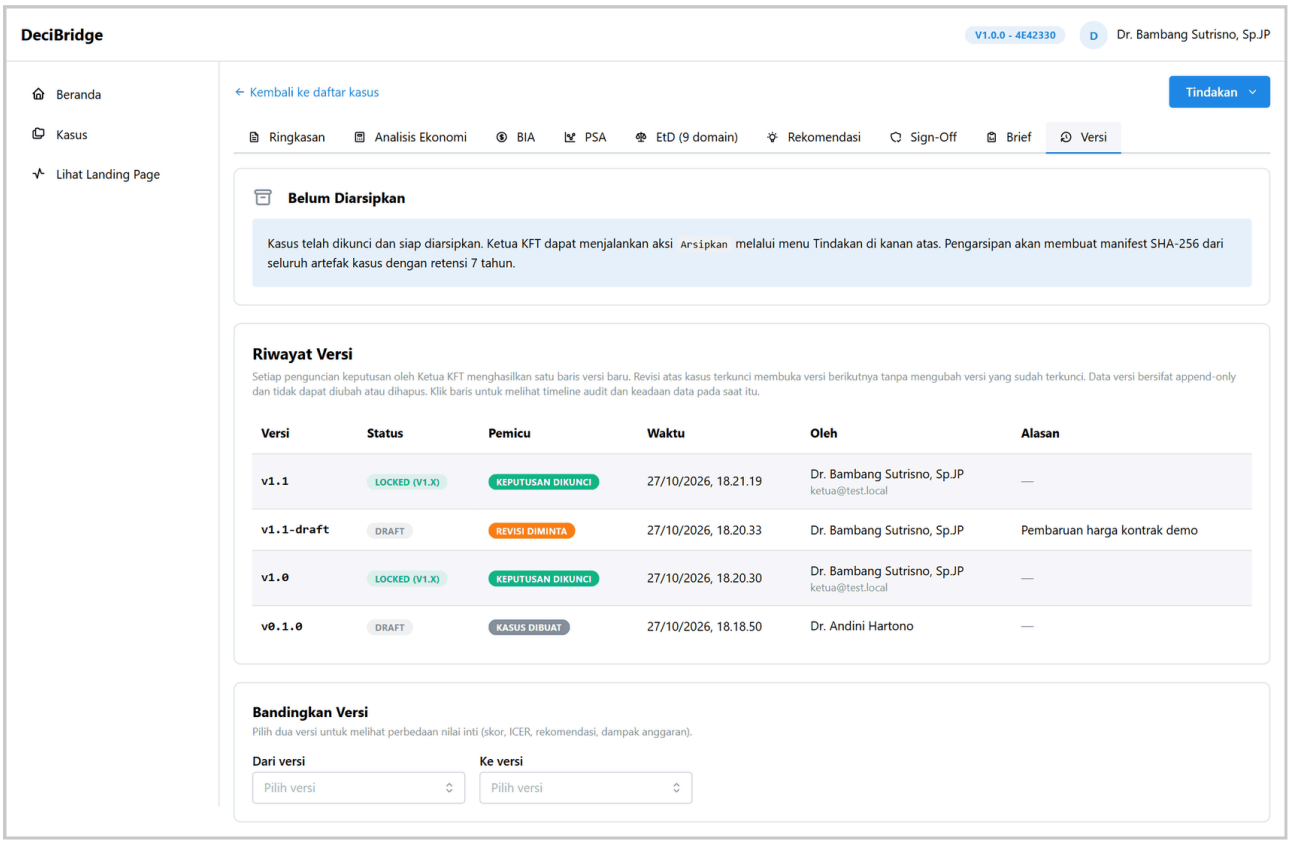
Gambar 45. Riwayat tanda tangan memuat dua persetujuan: untuk v1.0 dan untuk versi baru.



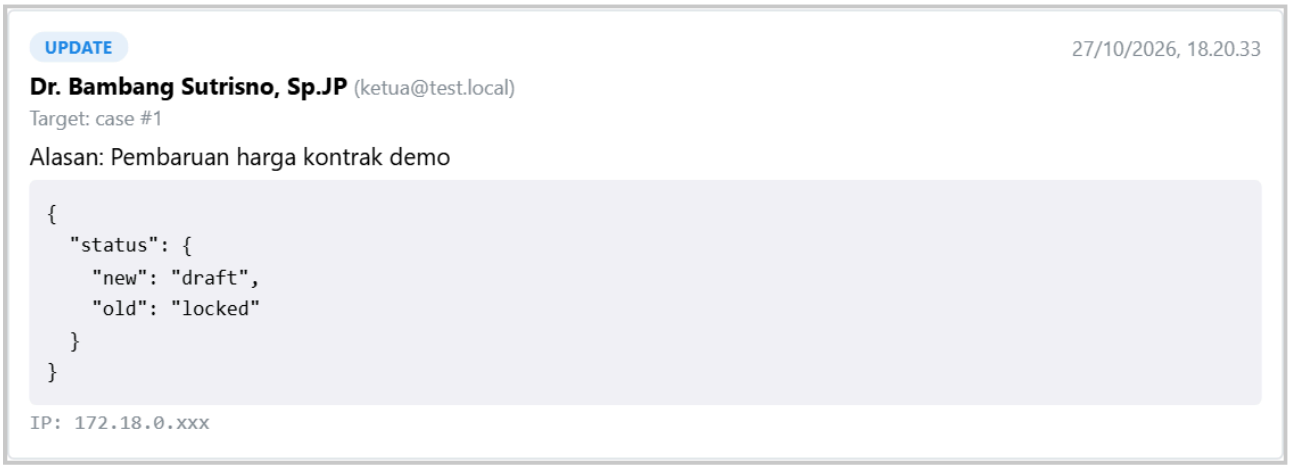
Gambar 46. Brief v2 terbit; v1 tetap dapat diunduh.

10.4 Membaca riwayat versi

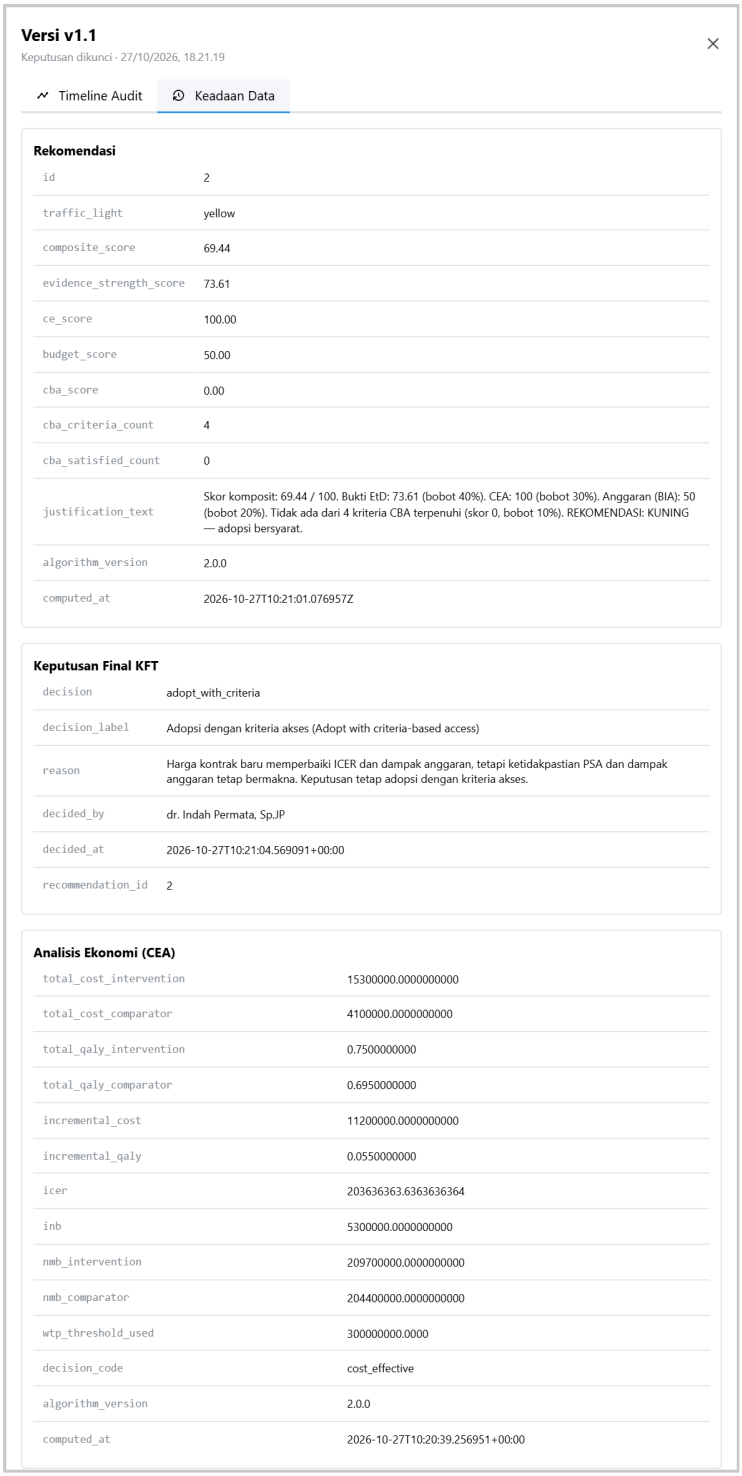
1. Buka tab **Versi**. Riwayat memuat **v0.1.0**, **v1.0**, baris **v1.1-draft** dengan pemicu **REVISI DIMINTA** dan alasannya, serta **v1.1**.
2. Klik baris **v1.1**. Tab **Timeline Audit** memuat seluruh perubahan sampai saat itu, termasuk pembuatan revisi beserta alasannya. Tab **Keadaan Data** memuat angka yang dibekukan pada versi itu.
3. Pada **Bandingkan Versi**, pilih v1.0 dan v1.1, lalu klik **Tampilkan Diff** untuk melihat angka yang berubah karena revisi harga.



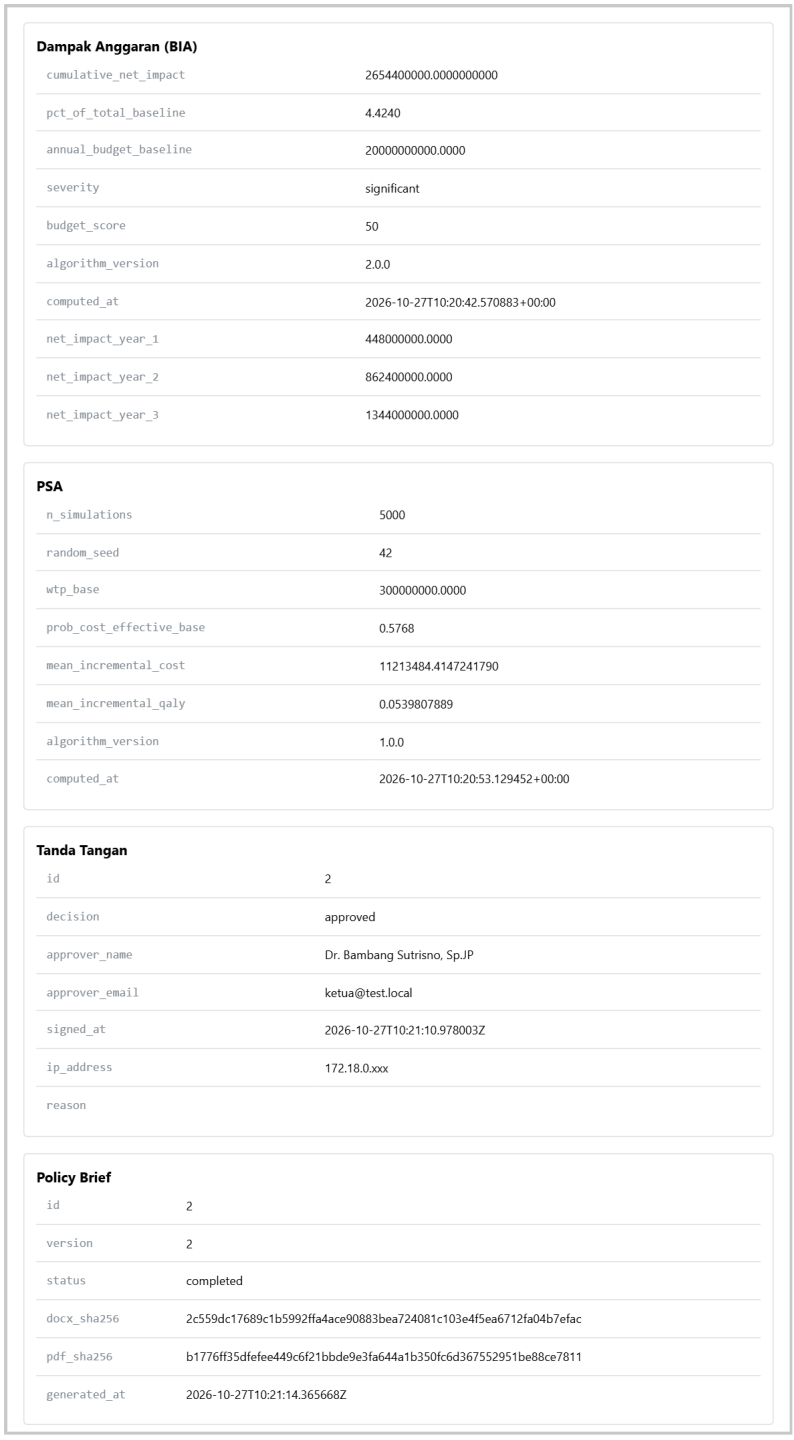
Gambar 47. Riwayat versi: v0.1.0, v1.0, revisi v1.1-draft beserta alasannya, dan v1.1.



Gambar 48. Entri Timeline Audit untuk pembuatan revisi, dengan alasannya.



Gambar 49. Keadaan Data versi 1.1: rekomendasi, Keputusan Final KFT dan analisis ekonomi yang dibekukan.



Dampak Anggaran (BIA)

cumulative_net_impact	2654400000.0000000000
pct_of_total_baseline	4.4240
annual_budget_baseline	20000000000.0000
severity	significant
budget_score	50
algorithm_version	2.0.0
computed_at	2026-10-27T10:20:42.570883+00:00
net_impact_year_1	448000000.0000
net_impact_year_2	862400000.0000
net_impact_year_3	1344000000.0000

PSA

n_simulations	5000
random_seed	42
wtp_base	300000000.0000
prob_cost_effective_base	0.5768
mean_incremental_cost	11213484.4147241790
mean_incremental_qaly	0.0539807889
algorithm_version	1.0.0
computed_at	2026-10-27T10:20:53.129452+00:00

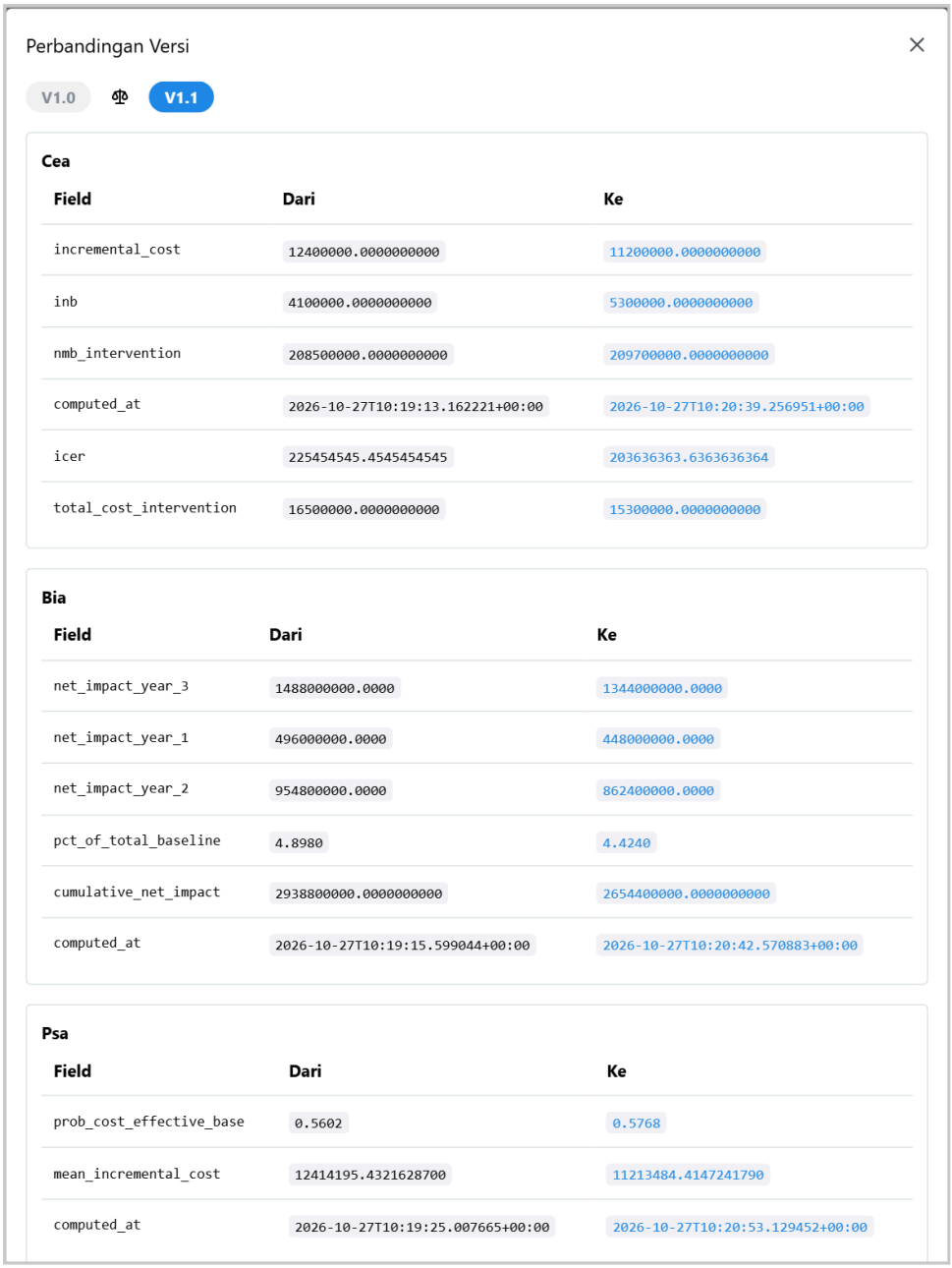
Tanda Tangan

id	2
decision	approved
approver_name	Dr. Bambang Sutrisno, Sp.JP
approver_email	ketua@test.local
signed_at	2026-10-27T10:21:10.978003Z
ip_address	172.18.0.xxx
reason	

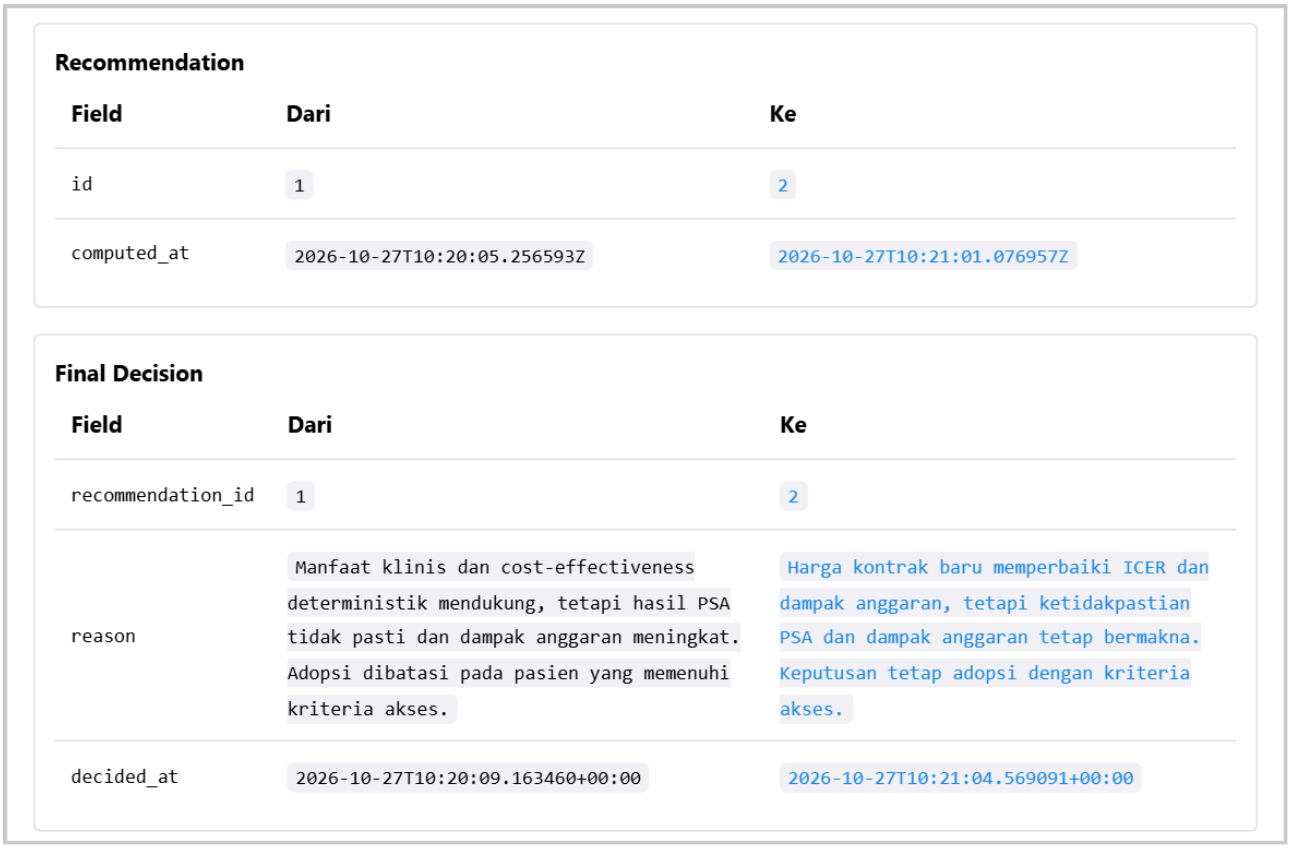
Policy Brief

id	2
version	2
status	completed
docx_sha256	2c559dc17689c1b5992ffa4ace90883bea724081c103e4f5ea6712fa04b7efac
pdf_sha256	b1776ff35dfefee449c6f21bbde9e3fa644a1b350fc6d367552951be88ce7811
generated_at	2026-10-27T10:21:14.365668Z

Gambar 50. Keadaan Data versi 1.1 (lanjutan): BIA, PSA, tanda tangan dan brief v2.



Gambar 51. Perbandingan v1.0 dan v1.1: angka yang berubah karena revisi harga.



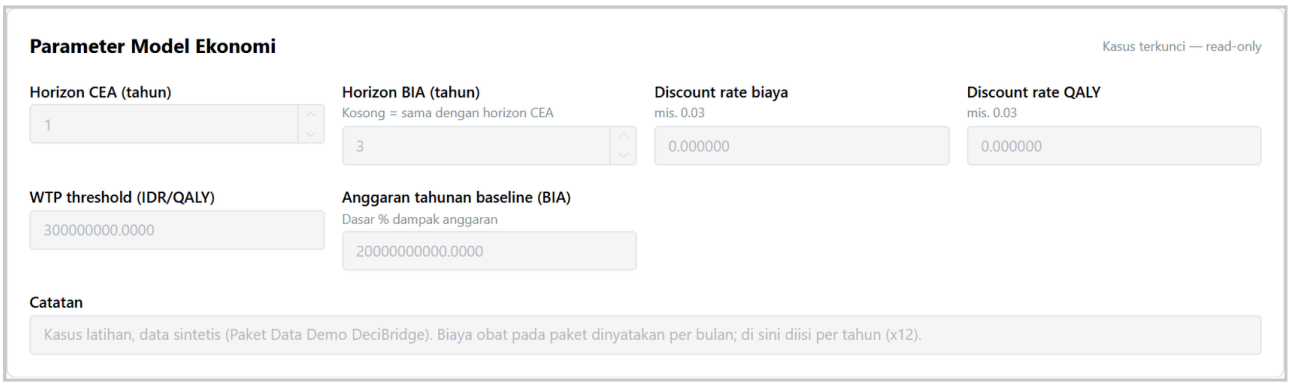
Recommendation

Field	Dari	Ke
id	1	2
computed_at	2026-10-27T10:20:05.256593Z	2026-10-27T10:21:01.076957Z

Final Decision

Field	Dari	Ke
recommendation_id	1	2
reason	Manfaat klinis dan cost-effectiveness deterministik mendukung, tetapi hasil PSA tidak pasti dan dampak anggaran meningkat. Adopsi dibatasi pada pasien yang memenuhi kriteria akses.	Harga kontrak baru memperbaiki ICER dan dampak anggaran, tetapi ketidakpastian PSA dan dampak anggaran tetap bermakna. Keputusan tetap adopsi dengan kriteria akses.
decided_at	2026-10-27T10:20:09.163460+00:00	2026-10-27T10:21:04.569091+00:00

Gambar 52. Perbandingan v1.0 dan v1.1 (lanjutan): rekomendasi dan Keputusan Final KFT tiap versi.



Gambar 53. Setelah dikunci, isian pada semua tab hanya dapat dibaca.

Yang perlu diketahui tentang versi

Penomoran paket v0.1 dan v0.2 sepadan dengan v1.0 dan v1.1 di dashboard: keduanya adalah keputusan yang sudah dikunci.

Versi baru selalu memerlukan Keputusan Final KFT dan tanda tangan Ketua KFT yang baru; yang dicatat untuk versi sebelumnya tidak berlaku lagi.

Kasus yang sudah diarsipkan adalah rekam keputusan resmi dan tidak dapat direvisi. Pengarsipan (Tindakan, **Arsipkan**, oleh Ketua KFT) tidak dibahas dalam panduan ini.

Lampiran A - Kunci hasil

Tabel berikut membandingkan hasil dashboard pada pengerjaan ini dengan 11_INSTRUCTOR_KEY. Hasil deterministik dan BIA harus sama persis; hasil BIA dan PSA ada pada Bab 4 dan Bab 5, dan hasil revisi pada Bab 10.

Tabel 16. Hasil deterministik dibanding kunci

Keluaran deterministik	Dashboard	Kunci instruktur	Status
Total cost - intervensi	Rp16.500.000	Rp16.500.000	Sesuai
Total cost - komparator	Rp4.100.000	Rp4.100.000	Sesuai
Incremental cost	Rp12.400.000	Rp12.400.000	Sesuai
QALY - intervensi	0,750	0,750	Sesuai
QALY - komparator	0,695	0,695	Sesuai
Incremental QALY	0,055	0,055	Sesuai
ICER per QALY	Rp225.454.545,45	Rp225.454.545,45	Sesuai
NMB - intervensi	Rp208.500.000	Rp208.500.000	Sesuai
NMB - komparator	Rp204.400.000	Rp204.400.000	Sesuai
INB	Rp4.100.000	Rp4.100.000	Sesuai

Kesimpulan belajar pada paket

Hasil deterministik tampak cost-effective pada WTP demo karena ICER sekitar Rp225,45 juta per QALY dan INB positif. Namun PSA hanya sekitar 56% cost-effective dan BIA naik sampai sekitar Rp1,488 miliar per tahun. Keputusan latihan yang koheren adalah adopsi dengan akses berbasis kriteria, bukan adopsi tanpa batas.

Lampiran B - Perbedaan paket latihan dan dashboard

Paket latihan ditulis untuk dashboard secara umum dan beberapa kali meminta pengguna memilih opsi terdekat. Tabel berikut mencatat setiap tempat build ini berbeda dari langkah paket, dan cara panduan ini menanganinya.

Tabel 17. Perbedaan langkah paket dan dashboard

Langkah	Pada paket	Pada dashboard (build ini)
1	Case ID DB_DEMO_HF_001	Di situs bersama ID itu sudah dipakai kasus rujukan. Gunakan ID sendiri.
9	Time horizon diisi di Ringkasan	Diisi di Analisis Ekonomi sebagai Horizon CEA.
10	Outcome diisi di Ringkasan	Diisi pada Outcome (O) di langkah PICO.
11-12	Biaya obat per bulan	Isian per pasien per tahun; nilai paket dikalikan 12.
25-33	Input BIA di menu BIA	Diisi di Analisis Ekonomi; tab BIA hanya menghitung dan menampilkan.
32	Market share baseline ARNI = 0	Tidak diisi. Market share di dashboard adalah pengali jumlah pasien; nilai 0 membuat BIA nol.
37-39	Distribusi per kelompok parameter	Diatur per parameter pada tab PSA. SE biaya diketik 10%; utility memakai SD.
41-49	Judgement dengan istilah tiap domain	Skala lima pilihan (Tidak sampai Ya) ditambah kepastian GRADE per domain. Padanannya pada Bab 6.
50	Decision type dipilih pengguna	Dipilih pada kartu Keputusan Final KFT (tab Rekomendasi) oleh Anggota atau Ketua KFT. Warna dan skor sistem tetap ditampilkan sebagai bahan pertimbangan.
51	Target population diisi di Rekomendasi	Tidak ada isian terpisah. Tercatat di Ringkasan dan pertanyaan PICO, dan dicetak pada brief sebagai Populasi target.
52	Access criteria	Diisi sebagai Kriteria Akses (CBA).
53	Rationale terintegrasi diisi pengguna	Ditulis sebagai Alasan pada Keputusan Final KFT (wajib). Sistem tetap menulis Justifikasi untuk rekomendasinya.
54	Checklist delapan butir, termasuk PSA	Kelengkapan Dossier memuat PSA pada input terbaru, rekomendasi yang masih sesuai input, dan Keputusan Final KFT; sign-off ditolak bila ada yang kurang.
55	Approver memilih keputusan	Ketua KFT menandatangani Keputusan Final KFT yang tercatat (atau mencatat keputusan baru lebih dulu); tanda tangan mengikat keputusan itu.
56	Brief memuat ringkasan PSA dan pertanyaan keputusan	Sama: brief memuat ringkasan PSA, pertanyaan keputusan, populasi target dan Keputusan Final KFT.
57	Versi awal disimpan sebagai v0.1	v0.1.0 dibuat otomatis ketika kasus dibuat.
58-59	Buat versi baru v0.2 dengan alasan	Keputusan dikunci sebagai v1.0, lalu **Buat Revisi (Versi Baru)** dengan alasan membuka versi berikutnya tanpa mengubah v1.0. Setelah dikunci ulang menjadi v1.1. Penomoran v1.0/v1.1 sepadan dengan v0.1/v0.2 pada paket.

Lampiran C - Masalah yang sering terjadi

Tabel 18. Masalah umum dan penyelesaiannya

Yang terlihat	Penyebab	Yang dilakukan
Pesan **Parameter belum tersimpan** dan ada baris bertanda merah	Proporsi diketik sebagai persen, misalnya 30 untuk 30%	Ketik 0.30. Tidak ada baris yang tersimpan sampai semua baris benar.
Belum dapat dihitung - input wajib yang kurang	Parameter belum disimpan, atau ada parameter wajib yang belum ada	Simpan parameter, lalu lengkapi yang disebut pada daftar.
Hasil BIA nol atau pasien nol	Market share diisi 0	Hapus baris market share, lalu hitung ulang.
Pilihan **Tahun 1** tidak ada saat menambah parameter	Horizon BIA belum diisi	Isi Horizon BIA 3 pada Parameter Model Ekonomi.
Tombol **Hitung PSA** tidak aktif	Ada perubahan distribusi yang belum disimpan	Klik Simpan Distribusi lebih dulu.
PSA **Belum dapat dihitung** dengan keterangan distribusi	Sebuah distribusi dipilih tetapi parameternya belum lengkap	Lengkapi baris yang disebut, atau kembalikan ke Tetap.
Peringatan **Hasil PSA ini tidak lagi sesuai input**	Parameter atau distribusi berubah setelah PSA dijalankan	Jalankan ulang PSA.
Peringatan **Rekomendasi ini tidak lagi sesuai input**	Analisis ekonomi, BIA, EtD atau kriteria berubah setelah rekomendasi dihitung	Klik Hitung Rekomendasi; sign-off dan penguncian ditolak sampai itu dilakukan.
Tombol **Setujui dengan Sign-Off** tidak aktif	Ada butir wajib pada Kelengkapan Dossier yang belum terpenuhi, misalnya PSA perlu dijalankan ulang atau Keputusan Final KFT belum dicatat	Lengkapi butir bertanda silang, lalu buka lagi tab Sign-Off.
Keputusan Final KFT minta **dikonfirmasi ulang**	Rekomendasi dihitung ulang, atau kasus sedang direvisi sebagai versi baru	Anggota atau Ketua KFT mencatat keputusan baru pada tab Rekomendasi.
Rekomendasi **Belum dapat dihitung**	Belum semua domain EtD terisi, atau analisis ekonomi atau BIA belum dihitung	Lengkapi komponen yang disebut pada daftar.
Dossier belum lengkap saat mengajukan atau menyetujui	Ada butir wajib pada Kelengkapan Dossier yang belum terpenuhi	Buka tab Sign-Off dan lengkapi butir bertanda silang.
Tombol **Terbitkan Ringkasan** tidak aktif	Kasus belum Disetujui, atau peran tidak berwenang	Minta sign-off Ketua KFT; terbitkan sebagai Analis HTA atau Ketua KFT.
Tidak ada isian yang dapat diubah	Kasus sudah Terkunci	Untuk mengubahnya, Analis HTA atau Ketua KFT memilih Tindakan, **Buat Revisi (Versi Baru)**, dengan alasan.